



HOME FEVER REMEDIES

SOLUSI PRAKTIS PENANGANAN DEMAM ANAK DI RUMAH

Faiza Yuniati
Sherli Shobur

HOME FEVER REMEDIES:
SOLUSI PRAKTIS PENANGANAN
DEMAM ANAK DI RUMAH

Penulis

Dr. Faiza Yuniati, S.Kep., M.KM.

Sherli Shobur, S.KM., M.KM.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Home Fever Remedies: Solusi Praktis Penanganan Demam Anak Di Rumah

Penulis: Dr. Faiza Yuniati, S.Kep., M.KM.
Sherli Shobur, S.KM, M.KM

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indarawan
Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7097-95-8

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga monograf ini yang berjudul **“Home Fever Remedies: Solusi Praktis Penanganan Demam Anak Di Rumah”** dapat diselesaikan dengan baik. Monograf ini hadir sebagai wujud kepedulian terhadap peran penting orang tua atau *caregiver* dalam menangani demam anak, yang merupakan salah satu kondisi kesehatan yang sering ditemui di lingkungan keluarga. Penulisan monograf ini dilatarbelakangi oleh temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, dan karakteristik orang tua memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penanganan demam anak di rumah. Penanganan demam yang efektif tidak hanya membantu meringankan kondisi anak, tetapi juga dapat mencegah komplikasi lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan panduan yang sistematis, praktis, dan mudah dipahami oleh orang tua maupun *caregiver*.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan monograf ini. Penulis menyadari bahwa monograf ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga monograf ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi sumbangsih positif dalam peningkatan kualitas kesehatan keluarga, khususnya dalam penanganan demam anak.

Selamat membaca.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 DEMAM..... 9

A. Definisi Demam	9
B. Klasifikasi Demam.....	10
C. Etiologi Demam.....	12
D. Patofisiologi Demam	15
E. Proses Fisiologis Yang Menyertai Demam	15
F. Manifestasi Klinis Demam	17
G. Pemeriksaan Klinis dan Penunjang	20
H. Penatalaksanaan Demam Pada Anak di Rumah	22
I. Pemantauan dan Tindakan Lanjut.....	33

BAB 3 FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENANGANAN DEMAM ANAK DI RUMAH.....35

A. Teori Lawrence Green dan Faktor yang Mempengaruhi Penanganan Demam	35
B. Faktor <i>Predisposing</i>	35
C. Status perkawinan/ keberadaan pasangan.....	37
D. Pendidikan.....	38
E. Pekerjaan dan Pendapatan	39
F. Pengetahuan.....	40
G. Sikap	40
H. Faktor enabling (Faktor Pemungkin).....	42
I. Faktor Reinforcing (Faktor Pendorong).....	43

BAB 4	MODEL PREDIKSI PENANGANAN DEMAM ANAK DI RUMAH.....	49
BAB 5	PENUTUP	65
	DAFTAR PUSTAKA.....	69
	GLOSARIUM	79
	PROFIL PENULIS	81

BAB 1

PENDAHULUAN

Demam adalah salah satu gejala klinis yang paling sering dijumpai pada anak-anak dan menjadi salah satu alasan utama untuk melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagai respons fisiologis tubuh terhadap infeksi atau peradangan, demam memiliki peran penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan patogen, seperti virus dan bakteri. Meskipun demam bukanlah penyakit itu sendiri, sering kali gejala ini dianggap sebagai indikator adanya masalah medis yang lebih serius, seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), flu, dan diare. Demam pada anak dapat muncul sebagai gejala dari berbagai penyakit infeksi yang memengaruhi anak, terutama pada kelompok usia balita yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum sepenuhnya matang (Dai & Lu, 2012; Gulcan & Sahiner, 2023)

Menurut data epidemiologi, demam memicu lebih dari 30% dari seluruh kunjungan ke fasilitas kesehatan anak (Wilson et al., 2019). Di Indonesia, prevalensi penyakit yang berhubungan dengan demam, seperti ISPA dan diare, cukup tinggi, terutama pada anak balita. Penyakit-penyakit ini sering menyebabkan demam yang berulang, bahkan pada kasus ringan sekalipun. Selain itu, prevalensi demam yang tinggi pada anak-anak di negara berkembang, termasuk Indonesia, berkontribusi pada angka kematian anak yang tinggi di seluruh dunia (Rahman & Hossain, 2022). Menurut data UNICEF, diperkirakan sebanyak 12 juta anak meninggal setiap tahun,

dengan sebagian besar kasusnya terkait dengan infeksi yang menyebabkan demam (UNICEF, 2019).

Demam pada anak-anak bukan hanya menjadi masalah medis, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Di wilayah dengan akses pelayanan kesehatan yang rendah, demam sering kali ditangani dengan cara yang tidak tepat, yang dapat menyebabkan peningkatan morbiditas dan komplikasi serius. Di Indonesia, prevalensi ISPA dan diare pada balita masih cukup tinggi, meskipun beberapa daerah telah melaporkan penurunan prevalensi penyakit ini dalam beberapa tahun terakhir. Riset Kesehatan Dasar Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi ISPA pada balita meskipun mengalami penurunan, namun tetap cukup tinggi, dengan angka prevalensi mencapai 9,4% pada tahun 2018 (Kemenkes RI, 2018).

Di wilayah kerja Puskesmas 4 Ulu Palembang, yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, prevalensi demam yang disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan dan diare pada anak-anak masih cukup tinggi. Pada tahun 2021, tercatat lebih dari 800 kasus diare pada balita dan 527 kunjungan dengan keluhan batuk dan sulit bernapas, yang menjadi salah satu indikator utama ISPA di daerah ini (Dinas Kesehatan Kota Palembang, 2022). Meskipun demikian, cakupan pelayanan kesehatan pada balita dan anak-anak di Puskesmas 4 Ulu hanya mencapai 28,5%, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Puskesmas lainnya di Kota Palembang, yang telah mencatatkan cakupan lebih dari 50%. Rendahnya cakupan pelayanan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses layanan kesehatan, yang berpotensi memperburuk kondisi kesehatan anak-anak di wilayah tersebut.

Anak-anak usia di bawah lima tahun memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum sepenuhnya berkembang, yang membuat mereka sangat rentan terhadap berbagai penyakit infeksi yang dapat menyebabkan demam. Selain infeksi virus dan bakteri, faktor lingkungan juga memengaruhi prevalensi demam pada anak-anak. Kondisi sanitasi yang buruk, paparan polusi, serta rendahnya tingkat pendidikan kesehatan di kalangan orang tua berkontribusi pada ketidaktahuan mengenai penanganan demam yang tepat. Hal ini membuat demam pada anak sering ditangani secara tidak tepat, seperti pemberian obat-obatan yang tidak sesuai atau penggunaan metode pendinginan fisik yang tidak berbasis bukti (Gulcan & Sahiner, 2023; Ng et al., 2023).

Penyebab paling umum dari demam pada anak adalah infeksi virus, yang dalam kebanyakan kasus dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan pengobatan medis yang intensif (Howard & Morgan, 2019). Meskipun demam biasanya merupakan respons tubuh terhadap infeksi, ia dapat menyebabkan berbagai gejala yang mengganggu kenyamanan anak, seperti sakit kepala, kelelahan, dan ketidaknyamanan lainnya. Pada kondisi demam yang lebih tinggi, jika tidak ditangani dengan benar, demam dapat berisiko menyebabkan komplikasi serius, seperti kejang demam, dehidrasi, dan kerusakan pada jaringan tubuh lainnya (Souza et al., 2022).

Sebagian besar orang tua cenderung melakukan penanganan demam di rumah, baik dengan metode farmakologis maupun non-farmakologis. Penggunaan antipiretik, seperti parasetamol dan ibuprofen, adalah metode yang paling umum digunakan untuk menurunkan suhu tubuh anak yang demam (Pitoli et al., 2021). Meskipun antipiretik dianggap efektif dalam mengurangi suhu tubuh, penggunaan obat-obatan ini seringkali tidak sesuai dengan dosis yang tepat

atau diberikan terlalu sering, yang dapat menimbulkan risiko efek samping seperti gangguan pada lambung, ginjal, atau hati (Elajez et al., 2021). Selain itu, penanganan fisik seperti kompres hangat atau dingin sering digunakan oleh orang tua untuk menurunkan demam, meskipun efektivitasnya masih diperdebatkan dalam literatur medis (Schellack & Schellack, 2018).

Penggunaan kompres hangat yang dianggap dapat memperlebar pembuluh darah perifer dan meningkatkan pengeluaran panas tubuh telah dibuktikan efektif dalam menurunkan demam pada anak-anak dalam beberapa studi. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kompres hangat hanya efektif dalam jangka pendek, dan setelah beberapa waktu, suhu tubuh anak bisa meningkat kembali, menyebabkan demam kambuh (Pereira et al., 2013). Di sisi lain, penggunaan kompres dingin, yang berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh dengan cara mengurangi pembuluh darah perifer, juga dapat menyebabkan efek samping seperti menggigil atau ketidaknyamanan pada anak (Chung, 2020).

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen demam di rumah antara lain adalah pengetahuan dan sikap orang tua, peran petugas kesehatan, serta dukungan keluarga. Pengetahuan orang tua tentang cara yang tepat dalam menangani demam dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan obat atau terapi fisik yang sesuai. Studi menunjukkan bahwa orang tua yang memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai demam dan cara penanganannya cenderung lebih mampu memberikan perawatan yang tepat kepada anak mereka (Setiani et al., 2022). Selain itu, peran petugas kesehatan, terutama perawat komunitas, sangat penting dalam memberikan edukasi kepada orang tua mengenai manajemen demam di rumah (Subedi et al., 2022).

Di wilayah Puskesmas 4 Ulu Palembang, tingkat pengetahuan orang tua tentang penanganan demam anak masih rendah, yang dapat dilihat dari tingginya angka penggunaan obat antipiretik yang tidak sesuai dengan pedoman medis. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya akses informasi yang valid mengenai cara penanganan demam yang tepat, serta rendahnya tingkat edukasi yang diberikan oleh petugas kesehatan di tingkat masyarakat. Dukungan keluarga juga memainkan peran penting dalam praktik manajemen demam di rumah. Ketika orang tua mendapatkan dukungan dari anggota keluarga lain dalam merawat anak yang demam, mereka lebih cenderung untuk merasa lebih tenang dan lebih mampu memberikan perawatan yang tepat (Raak et al., 2022).

Peran petugas kesehatan, khususnya di komunitas, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara penanganan demam yang tepat sangat krusial, terutama di daerah dengan cakupan layanan kesehatan yang rendah seperti Puskesmas 4 Ulu Palembang. Perawat komunitas memiliki peran penting dalam mendidik orang tua mengenai cara-cara yang benar untuk menangani demam anak, serta pentingnya deteksi dini dan pemantauan suhu tubuh anak. Dengan pendekatan edukasi yang lebih sistematis, diharapkan orang tua dapat lebih memahami pentingnya penanganan demam yang tepat dan menghindari kesalahan dalam pemberian obat atau penggunaan metode non-farmakologis yang tidak efektif.

Dengan meningkatnya pengetahuan orang tua mengenai manajemen demam di rumah, diharapkan akan ada penurunan jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan untuk kasus demam yang sebenarnya dapat ditangani secara mandiri di rumah. Hal ini akan mengurangi beban di fasilitas kesehatan dan meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen demam di rumah pada anak-anak, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan seperti di wilayah Puskesmas 4 Ulu Palembang.

Demam pada anak merupakan gejala klinis yang sering menyebabkan orang tua membawa anak mereka ke fasilitas pelayanan kesehatan. Meskipun demam pada umumnya bukan kondisi yang mengancam jiwa, pengelolaannya yang tidak tepat dapat berisiko menimbulkan komplikasi serius, seperti dehidrasi, kejang, atau kerusakan organ tubuh lainnya. Penanganan demam yang tepat sangat penting untuk menghindari peningkatan morbiditas dan komplikasi yang lebih lanjut. Di banyak daerah, terutama di wilayah dengan akses terbatas ke layanan kesehatan seperti di Puskesmas 4 Ulu Palembang, pengetahuan orang tua mengenai manajemen demam yang tepat masih rendah. Hal ini sering kali menyebabkan praktik pengelolaan demam yang keliru, yang dapat memperburuk kondisi anak dan meningkatkan beban kesehatan masyarakat.

Di wilayah Puskesmas 4 Ulu Palembang, meskipun prevalensi penyakit yang menyebabkan demam, seperti ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dan diare, cukup tinggi, cakupan pelayanan kesehatan pada balita dan anak-anak masih tergolong rendah, yaitu hanya 28,5%. Tingginya prevalensi penyakit yang berhubungan dengan demam dan rendahnya cakupan pelayanan kesehatan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penanganan demam yang tepat. Sementara itu, praktik penanganan demam di rumah oleh orang tua masih bervariasi dan tidak selalu didasarkan pada pedoman medis yang benar. Kesalahan dalam penanganan demam,

seperti pemberian obat yang tidak sesuai atau penggunaan metode non-farmakologis yang tidak berbasis bukti, sering terjadi dan dapat menambah risiko komplikasi.

Kurangnya informasi yang memadai dan rendahnya tingkat pengetahuan orang tua tentang manajemen demam yang tepat menjadikan penanganan demam di rumah sering kali tidak sesuai dengan standar medis. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan demam di rumah, seperti pengetahuan dan sikap orang tua, serta peran petugas kesehatan dan dukungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan home fever management dan diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan pendidikan kesehatan di masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman orang tua tentang cara yang tepat dalam menangani demam anak-anak di rumah.

Praktik penanganan demam di rumah (*home fever management*) oleh orang tua pada anak-anak yang mengalami demam seringkali tidak dilakukan dengan tepat, meskipun demam adalah gejala yang umum dan dapat ditangani tanpa intervensi medis yang serius. Penanganan yang tidak tepat dapat menyebabkan peningkatan morbiditas dan komplikasi serius, seperti dehidrasi, kejang, atau gangguan pada organ tubuh lainnya. Data dari Puskesmas 4 Ulu Palembang menunjukkan bahwa prevalensi demam pada anak-anak masih cukup tinggi, dengan lebih dari 500 kasus ISPA dan lebih dari 800 kasus diare pada balita pada tahun 2021 dan 2022. Di sisi lain, cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas ini sangat rendah, yaitu hanya 28,5%, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelayanan kesehatan.

Selain itu, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen demam di rumah pada anak-anak di wilayah Puskesmas 4 Ulu Palembang. Praktik penanganan demam oleh orang tua seringkali dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pengetahuan dan sikap orang tua terhadap demam, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, serta peran petugas kesehatan dan dukungan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan manajemen demam di rumah pada anak-anak, sehingga dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dan masyarakat dalam menangani demam anak dengan lebih tepat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bidang Kesehatan masyarakat, khususnya dalam manajemen demam anak di rumah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pedoman dan program edukasi bagi orang tua, khususnya yang tinggal di daerah dengan cakupan pelayanan kesehatan yang rendah, mengenai penanganan demam yang tepat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi penting bagi tenaga kesehatan dalam mengedukasi masyarakat tentang cara yang benar dalam menangani demam anak di rumah. Diharapkan dengan meningkatkan pengetahuan orang tua dan masyarakat, angka kunjungan ke fasilitas kesehatan untuk menangani demam anak dapat berkurang, serta menurunkan risiko komplikasi yang dapat terjadi akibat penanganan yang tidak tepat.

BAB 2

DEMAM

A. Definisi Demam

Demam adalah suatu keadaan di mana suhu tubuh meningkat di atas batas normal akibat perubahan pada pusat pengatur suhu di hipotalamus. Pada umumnya, suhu tubuh normal manusia berkisar antara 36,5°C hingga 37,5°C, tergantung pada metode pengukuran dan waktu pengukuran. Namun, ketika tubuh mengalami infeksi atau peradangan, hipotalamus akan mengatur suhu tubuh untuk naik lebih tinggi sebagai bagian dari respon tubuh untuk melawan patogen (Carroll & Klein, 20019).

Demam pada anak-anak sering kali merupakan respons fisiologis tubuh terhadap infeksi, baik yang disebabkan oleh virus maupun bakteri. Sebagian besar kasus demam pada anak bersifat ringan dan bersifat sementara, serta dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 1-3 hari tanpa memerlukan perawatan medis intensif (Raak et al., 2022). Namun, meskipun demam sering kali merupakan gejala yang tidak berbahaya, dalam beberapa kasus, demam yang tinggi dapat menjadi tanda adanya infeksi serius yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut, seperti pneumonia, meningitis, atau sepsis (Carroll & Klein, 20019).

Menurut definisi dalam Stedman's Medical Dictionary, demam adalah peningkatan suhu tubuh yang melebihi 37,8°C (100°F). Dalam protokol Kaiser Permanente, demam pada semua usia didefinisikan sebagai temperatur rektal di atas 38°C, aksilar di atas 37,5°C, dan suhu membran timpani

lebih dari 38,2°C. Sementara itu, demam tinggi didefinisikan sebagai suhu tubuh di atas 39,5°C, dan hiperpireksia terjadi bila suhu tubuh melebihi 41,1°C (Carroll & Klein, 20019).

Penyebab utama demam pada anak-anak adalah infeksi yang disebabkan oleh virus, seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), influenza, dan infeksi gastrointestinal (diare). Namun, demam juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, seperti pneumonia, meningitis, dan infeksi saluran kemih. Di luar infeksi, demam dapat juga terjadi akibat keadaan non-infeksi, seperti reaksi terhadap vaksin, obat-obatan, atau bahkan penyakit autoimun dan keganasan (Carlson & Kurnia, 2020).

Demam dapat terjadi akibat dua jenis pirogen yang memengaruhi tubuh, yaitu pirogen eksogen dan pirogen endogen. Pirogen eksogen berasal dari luar tubuh dan dapat merangsang reaksi hipertermia dengan mempengaruhi kerja sitokin dalam tubuh. Pirogen endogen, yang berasal dari dalam tubuh, merangsang pusat pengatur suhu di hipotalamus dan menyebabkan peningkatan suhu tubuh (Carlson & Kurnia, 2020). Penyebab lainnya termasuk reaksi terhadap obat-obatan, gangguan pusat regulasi suhu sentral seperti perdarahan otak, atau gangguan metabolik lainnya yang dapat mempengaruhi mekanisme homeostasis suhu tubuh (Gulcan & Sahiner, 2023).

B. Klasifikasi Demam

Demam dapat diklasifikasikan berdasarkan pola perubahan suhu tubuh dan durasi demam itu sendiri. Beberapa klasifikasi umum yang sering digunakan antara lain (Berman, A., Kozier, B. & Erb, 2015):

1. Demam Intermitten Demam jenis ini ditandai dengan fluktuasi suhu tubuh yang teratur antara suhu normal dan

suhu tinggi dalam rentang waktu tertentu. Dalam kondisi ini, suhu tubuh naik ke tingkat yang lebih tinggi dan kemudian turun ke suhu normal dalam periode yang teratur. Jika fluktuasi suhu ini terjadi setiap dua kali sehari, kondisi ini disebut *tertiary fever*, sementara jika terjadi dua hari tanpa peningkatan suhu di antara dua periode demam, maka disebut *quartan fever*.

2. Demam Remitten Pada demam remitten, suhu tubuh anak dapat turun setiap hari, tetapi tidak mencapai suhu tubuh normal. Suhu tubuh akan mengalami variasi lebih dari 2°C dalam periode waktu 24 jam, namun tidak pernah turun ke suhu normal. Demam ini sering ditemukan pada penyakit infeksi yang berlangsung lebih lama dan tidak menunjukkan pola penurunan suhu yang konsisten.
3. Demam Siklik Demam jenis ini dicirikan dengan kenaikan suhu tubuh yang terjadi selama beberapa hari, diikuti oleh periode bebas demam selama beberapa hari, sebelum suhu tubuh kembali naik lagi. Demam siklik sering kali terkait dengan penyakit-penyakit tertentu yang memiliki siklus khas dalam gejalanya, seperti malaria dan demam tifoid.
4. Demam Septik Demam septik ditandai dengan peningkatan suhu tubuh yang drastis, terutama pada malam hari, yang diikuti dengan penurunan suhu tubuh pada pagi hari. Demam jenis ini sering disertai dengan keluhan menggigil dan berkeringat. Pada beberapa kasus, demam tinggi yang turun ke tingkat normal disebut juga sebagai *hectic fever*. Demam jenis ini biasanya terjadi pada infeksi berat atau kondisi sepsis yang mengancam jiwa.
5. Demam Kontinyu Pada demam kontinyu, suhu tubuh tetap tinggi secara konsisten tanpa banyak fluktuasi

sepanjang hari, meskipun variasinya tidak lebih dari satu derajat. Jika suhu tubuh terus-menerus tinggi tanpa penurunan signifikan, kondisi ini dapat berkembang menjadi hiperpireksia, yang merupakan peningkatan suhu tubuh yang sangat tinggi (lebih dari 41°C) dan berisiko mengancam jiwa.

C. Etiologi Demam

Demam merupakan respons fisiologis tubuh yang dipicu oleh berbagai faktor. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya demam adalah pirogen. Pirojen adalah zat yang dapat merangsang peningkatan suhu tubuh dengan mempengaruhi pusat pengatur suhu di hipotalamus. Pirojen dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pirogen eksogen dan pirogen endogen. Pirogen eksogen berasal dari luar tubuh, seperti mikroorganisme patogen (bakteri, virus, dan jamur), toksin, atau antigen dari vaksin. Sementara itu, pirogen endogen diproduksi oleh tubuh sendiri sebagai respons terhadap infeksi atau cedera dan berfungsi untuk merangsang terjadinya demam.

Pirogen eksogen, terutama yang berasal dari mikroorganisme, bekerja dengan mempengaruhi tubuh untuk memproduksi zat pirogen endogen, yang kemudian bertindak untuk mengatur suhu tubuh. Pirogen endogen yang utama adalah interleukin-1 (IL-1), interleukin-6 (IL-6), faktor nekrosis tumor (TNF- α), dan interferon (IFN- α). Zat-zat ini berperan dalam merangsang hipotalamus untuk mengatur ulang titik ambang suhu tubuh, yang pada gilirannya akan meningkatkan suhu tubuh dan memulai proses demam (Carlson & Kurnia, 2020).

Selain infeksi, demam juga dapat dipicu oleh berbagai faktor non-infeksius. Penyebab demam non-infeksius antara

lain reaksi terhadap obat-obatan, gangguan autoimun, penyakit inflamasi kronis, penyakit endokrin, dan neoplasma (keganasan). Misalnya, penggunaan obat-obatan seperti antibiotik, antikonvulsan, atau imunoterapi dapat menyebabkan reaksi alergi atau toksik yang memicu demam. Demam juga dapat terjadi pada kondisi seperti perdarahan otak atau koma, di mana gangguan pada pusat pengatur suhu sentral mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur suhu (Gulcan & Sahiner, 2023).

1. Pirogen Eksogen

Pirogen eksogen adalah bahan dari luar tubuh yang dapat merangsang terjadinya demam. Sebagian besar pirogen eksogen berasal dari mikroorganisme patogen, baik bakteri, virus, maupun jamur. Bakteri, misalnya, dapat menghasilkan endotoksin, yang merupakan komponen sel bakteri yang dapat memicu respon imun tubuh dan meningkatkan suhu tubuh. Endotoksin, terutama dari bakteri Gram-negatif, dapat merangsang produksi pirogen endogen yang menyebabkan demam.

Selain itu, virus dan jamur juga berperan sebagai pirogen eksogen. Virus seperti influenza, rhinovirus, dan dengue dapat memicu demam pada anak-anak dan dewasa. Virus ini merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengeluarkan sitokin pirogenik yang meningkatkan suhu tubuh. Jamur seperti *Candida* atau *Aspergillus* juga dapat menghasilkan pirogen eksogen yang mempengaruhi regulasi suhu tubuh (Berman, A., Kozier, B. & Erb, 2015).

Endotoksin adalah pirogen eksogen yang paling dikenal, ditemukan pada bakteri Gram-negatif seperti *Escherichia coli*, *Salmonella*, dan *Pseudomonas aeruginosa*. Endotoksin bekerja dengan cara

mengaktifkan sistem imun tubuh, yang kemudian merangsang produksi sitokin pirogenik seperti IL-1 dan TNF- α . Proses ini berujung pada perubahan titik ambang suhu tubuh di hipotalamus dan terjadinya demam (Gulcan & Sahiner, 2023).

2. Pirogen Endogen

Pirogen endogen adalah molekul yang diproduksi oleh tubuh sebagai respons terhadap infeksi atau peradangan. Molekul-molekul ini berperan untuk memodifikasi pusat pengatur suhu di hipotalamus dan menyebabkan terjadinya demam. Interleukin-1 (IL-1), interleukin-6 (IL-6), faktor nekrosis tumor (TNF- α), dan interferon adalah beberapa pirogen endogen utama yang terlibat dalam mekanisme ini.

Ketika tubuh terpapar dengan infeksi atau cedera, sel-sel imun seperti makrofag, neutrofil, dan limfosit melepaskan sitokin pirogenik ini. IL-1, misalnya, akan berikatan dengan reseptor di hipotalamus, yang mengarah pada peningkatan suhu tubuh. IL-1 bekerja dengan merangsang produksi prostaglandin E2 (PGE2), yang berperan dalam mengatur titik ambang suhu tubuh yang baru, sehingga tubuh mengalami demam (Kozier, 2012).

Selain IL-1, TNF- α dan IL-6 juga berperan penting dalam meningkatkan suhu tubuh. TNF- α , yang diproduksi oleh makrofag dan sel-sel imun lainnya, dapat menyebabkan peradangan dan memodulasi sistem imun tubuh untuk mengaktifkan mekanisme demam. Proses ini merupakan bagian dari respons tubuh terhadap infeksi dan bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen dan mempercepat pemulihan tubuh.

D. Patofisiologi Demam

Mekanisme terjadinya demam dimulai dengan adanya interaksi antara pirogen (baik eksogen maupun endogen) dan pusat pengatur suhu di hipotalamus. Ketika pirogen memasuki tubuh, mereka merangsang sel-sel imun untuk melepaskan sitokin pirogenik seperti IL-1, TNF- α , dan IL-6. Sitokin ini berikatan dengan reseptor pada hipotalamus, yang mengubah titik ambang suhu tubuh (set point) menjadi lebih tinggi (Carlson & Kurnia, 2020). Proses ini dimulai saat pirogen eksogen, seperti endotoksin, memasuki tubuh dan diakui oleh sistem imun tubuh. Sel-sel imun, seperti makrofag, kemudian melepaskan sitokin pirogenik yang berfungsi untuk meningkatkan suhu tubuh. Prostaglandin E2 (PGE2), yang diproduksi sebagai respons terhadap pirogen, memainkan peran penting dalam mengubah set point suhu tubuh di hipotalamus. Dengan peningkatan set point, tubuh merespons dengan menaikkan suhu tubuh, sehingga demam terjadi (Gulcan & Sahiner, 2023).

Proses pengaturan suhu yang baru ini menyebabkan tubuh melakukan berbagai respons fisiologis, seperti vasokonstriksi untuk mengurangi kehilangan panas, serta peningkatan metabolisme untuk menghasilkan lebih banyak panas. Pada saat yang sama, tubuh juga akan mencoba meningkatkan produksi energi melalui peningkatan laju metabolisme, yang meningkatkan suhu tubuh secara keseluruhan (Kozier, 2012).

E. Proses Fisiologis Yang Menyertai Demam

Setelah titik ambang suhu tubuh dinaikkan oleh pirogen, tubuh berusaha untuk mencapai suhu tubuh yang baru dengan berbagai mekanisme fisiologis. Salah satu mekanisme pertama adalah vasokonstriksi pada pembuluh

darah perifer. Vasokonstriksi ini bertujuan untuk mengurangi kehilangan panas dari tubuh, dengan mempersempit pembuluh darah di kulit dan mengarahkan darah ke organ vital (hipotalamus, jantung, paru-paru) yang membutuhkan lebih banyak oksigen (Carlson & Kurnia, 2020).

Selama fase ini, anak-anak yang demam sering kali merasa kedinginan, meskipun suhu tubuh mereka sedang meningkat. Tubuh mulai menggigil untuk menghasilkan lebih banyak panas. Shivering thermogenesis, atau proses menggigil, merupakan mekanisme tubuh untuk menghasilkan panas melalui kontraksi otot yang cepat (Kozier, 2012). Ketika suhu tubuh akhirnya mencapai set point yang baru di hipotalamus, tubuh mulai merasakan rasa panas dan proses menggigil pun berhenti.

1. Efek Prostaglandin E2 pada Hipotalamus

Prostaglandin E2 (PGE2) memainkan peran penting dalam pengaturan suhu tubuh selama demam. PGE2 diproduksi di hipotalamus setelah adanya rangsangan dari pirogen, baik eksogen maupun endogen. Prostaglandin E2 bertindak untuk meningkatkan suhu tubuh dengan merangsang produksi energi melalui peningkatan metabolisme (Carlson & Kurnia, 2020). Selain itu, PGE2 juga berperan dalam memperbesar efek vasokonstriksi, mengurangi kehilangan panas melalui kulit, dan meningkatkan suhu tubuh secara keseluruhan.

Peningkatan suhu tubuh melalui pengaruh PGE2 bertujuan untuk memperlambat pertumbuhan patogen, karena banyak mikroorganisme, terutama bakteri dan virus, tidak dapat berkembang biak dengan baik pada suhu tinggi. Oleh karena itu, demam dapat membantu tubuh dalam memerangi infeksi, meskipun dalam

beberapa kasus demam yang sangat tinggi dapat berisiko bagi kesehatan (Gulcan & Sahiner, 2023).

2. Respon tubuh terhadap Demam yang Terlalu Tinggi

Meskipun demam memiliki manfaat dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh, demam yang terlalu tinggi atau berlangsung lama dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan organ. Demam yang sangat tinggi, misalnya lebih dari 40°C, dapat menyebabkan kerusakan pada protein tubuh dan sistem enzimatik, yang berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan organ seperti otak, jantung, dan ginjal (Kozier, 2012).

Pada suhu tubuh yang sangat tinggi, proses metabolik tubuh menjadi terganggu. Peningkatan suhu tubuh yang drastis dapat mempercepat konsumsi oksigen dalam tubuh dan meningkatkan kerja jantung dan paru-paru. Hal ini dapat menambah beban pada organ-organ vital dan memicu berbagai komplikasi seperti kejang demam, kegagalan organ, atau kerusakan sel saraf (Gulcan & Sahiner, 2023).

F. Manifestasi Klinis Demam

Demam pada anak merupakan gejala klinis yang sering ditemukan, yang dapat menunjukkan adanya infeksi atau kondisi patologis lainnya. Gejala klinis yang menyertai demam dapat bervariasi tergantung pada penyebab yang mendasari dan tingkat keparahan infeksi atau kondisi lainnya. Demam biasanya terjadi dalam tiga fase yang saling berurutan: fase awal (terjadi peningkatan suhu tubuh), fase demam (proses berlangsung), dan fase pemulihan (penurunan suhu tubuh) (Carroll & Klein, 20019).

1. Fase I (Awitan Dingin atau Menggigil) Pada fase ini,

Suhu tubuh mulai meningkat, dan anak akan mengalami menggigil atau kedinginan. Gejala lainnya yang sering terjadi meliputi:

- a. Peningkatan denyut jantung: Sebagai respons tubuh untuk meningkatkan sirkulasi darah dan membantu peningkatan suhu tubuh.
- b. Peningkatan laju pernapasan: Untuk mengimbangi peningkatan metabolisme tubuh yang terjadi selama demam.
- c. Kulit pucat dan dingin: Akibat vasokonstriksi, yang terjadi untuk mengurangi kehilangan panas melalui kulit.
- d. Sensasi dingin: Anak merasa kedinginan meskipun suhu tubuhnya meningkat.
- e. Dasar kuku sianosis: Karena pengurangan aliran darah ke ekstremitas.
- f. Rambut kulit berdiri: Efek dari peningkatan suhu tubuh dan reaksi tubuh terhadap dingin.
- g. Pengeluaran keringat berlebihan: Sebagai reaksi terhadap peningkatan metabolisme tubuh.
- h. Peningkatan suhu tubuh: Pada titik ini, tubuh berusaha mencapai titik ambang suhu baru yang lebih tinggi.

2. Fase II (Proses Demam)

Pada fase ini, suhu tubuh tetap tinggi dan mencapai titik maksimum, sementara tubuh berusaha untuk mengatasi demam.

Gejala pada fase ini meliputi:

- a. Proses menggigil hilang: Setelah suhu tubuh mencapai titik ambang yang baru, anak akan merasa panas dan menggigil berhenti.

- b. Kulit terasa hangat (panas): Kulit terasa panas karena peningkatan suhu tubuh.
- c. Merasa tidak panas (dingin): Anak merasa sejuk meskipun suhu tubuh tetap tinggi, karena reaksi dari pusat pengatur suhu tubuh.
- d. Peningkatan nadi dan laju pernapasan: Tubuh meningkatkan aktivitas jantung dan paru untuk mendukung metabolisme yang lebih tinggi.
- e. Peningkatan rasa haus: Dehidrasi ringan dapat terjadi akibat peningkatan suhu tubuh dan evaporasi cairan tubuh.
- f. Dehidrasi ringan hingga berat: Kehilangan cairan yang signifikan dapat terjadi, terutama jika anak tidak cukup minum.
- g. Mengantuk, delirium, atau kejang: Pada kasus demam tinggi, gejala neurologis seperti kejang atau kebingungan dapat muncul akibat peningkatan suhu tubuh yang mempengaruhi otak.
- h. Lesi mulut: Mulut kering atau sariawan bisa muncul pada demam tinggi, terutama jika terjadi dehidrasi.
- i. Kehilangan nafsu makan: Anak mungkin menolak makanan karena rasa tidak nyaman atau mual akibat demam.
- j. Kelemahan, kelelahan, dan nyeri ringan pada otot: Dampak dari proses katabolisme protein tubuh selama demam.

3. Fase III (Pemulihan)

Pada fase pemulihan, suhu tubuh mulai menurun dan kembali ke tingkat normal.

Gejala pada fase ini meliputi:

- a. Kulit tampak merah dan hangat: Proses vasodilatasi terjadi untuk melepaskan panas tubuh.

- b. Berkeringat: Tubuh mengeluarkan keringat berlebihan untuk menurunkan suhu tubuh.
- c. Menggigil ringan: Beberapa anak mungkin merasa sedikit menggigil saat suhu tubuh menurun ke tingkat normal.
- d. Kemungkinan mengalami dehidrasi: Dehidrasi ringan hingga sedang masih dapat terjadi setelah fase demam.

G. Pemeriksaan Klinis dan Penunjang

Pemeriksaan medis yang dilakukan pada anak dengan demam bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab demam dan mengevaluasi kondisi umum anak. Pemeriksaan ini terbagi menjadi pemeriksaan klinis (pemeriksaan fisik) dan pemeriksaan penunjang (laboratorium atau radiologi).

1. Pemeriksaan Fisik.

Pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tenaga medis dimulai dengan anamnesis atau wawancara terkait durasi dan karakteristik demam, serta gejala-gejala lain yang menyertai. Pemeriksaan fisik meliputi:

- a. Pengukuran suhu tubuh: Menggunakan termometer digital, termometer infra merah, atau termometer rektal untuk mengukur suhu tubuh dengan tepat (Carroll & Klein, 20019). Pengukuran suhu tubuh secara akurat sangat penting untuk menentukan apakah anak mengalami demam yang perlu ditangani lebih lanjut.
- b. Pemeriksaan tanda vital: Meliputi pemeriksaan nadi, laju pernapasan, dan tekanan darah untuk menilai apakah ada komplikasi terkait demam, seperti sepsis atau syok.

- c. Pemeriksaan kulit dan mukosa: Memeriksa adanya tanda-tanda dehidrasi (kulit kering, bibir pecah-pecah, mata cekung) atau ruam yang mungkin muncul terkait dengan infeksi tertentu.
- d. Pemeriksaan neurologis: Untuk mengevaluasi jika ada gejala kejang atau perubahan status mental seperti delirium, terutama pada demam yang sangat tinggi.
- e. Palpasi abdomen dan pemeriksaan sistemik lainnya: Untuk mengidentifikasi kemungkinan infeksi perut, ginjal, atau masalah internal lainnya yang mungkin menyebabkan demam.

2. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan penunjang diperlukan untuk menentukan penyebab infeksi atau kondisi medis yang mendasari demam. Beberapa pemeriksaan yang umum dilakukan adalah:

- a. Pemeriksaan darah lengkap: Untuk mengevaluasi adanya tanda-tanda infeksi bakteri atau virus, seperti leukositosis atau limfositosis. Pada kasus demam berdarah, misalnya, trombositopenia dan hemokonsentrasi dapat terlihat.
- b. Kultur darah: Digunakan untuk mengidentifikasi patogen yang mungkin menyebabkan demam, terutama dalam kasus infeksi bakterial yang berat, seperti sepsis.
- c. Pemeriksaan urin dan feses: Diperlukan untuk menilai kemungkinan infeksi saluran kemih atau infeksi gastrointestinal yang dapat menyebabkan demam.
- d. Pemeriksaan radiologi: Seperti foto rontgen dada, dapat dilakukan untuk mendeteksi infeksi saluran

pernapasan, seperti pneumonia, yang dapat menyebabkan demam tinggi (Carroll & Klein, 2019).

Pemeriksaan penunjang ini memberikan informasi yang lebih rinci tentang penyebab demam dan memungkinkan dokter untuk menentukan pengobatan yang tepat. Dalam kasus demam yang tidak diketahui penyebabnya, pemeriksaan lanjutan seperti kultur mikroba, PCR (polymerase chain reaction), atau pemeriksaan serologis mungkin diperlukan untuk mengidentifikasi agen penyebab infeksi secara lebih spesifik.

H. Penatalaksanaan Demam Pada Anak di Rumah

Demam adalah respons alami tubuh terhadap infeksi dan merupakan salah satu gejala infeksi tubuh yang paling umum ditemukan pada anak-anak. Penanganan demam di rumah melibatkan kombinasi tindakan untuk mengurangi ketidaknyamanan anak, memantau kondisi mereka, dan mencegah komplikasi. Pada tingkat tertentu demam merupakan bagian dari pertahanan tubuh antara lain daya fagositosis meningkat dan viabilitas kuman menurun, tetapi dapat juga merugikan karena anak menjadi gelisah, nafsu makan dan minum berkurang, tidak dapat tidur dan menimbulkan kejang demam. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar orangtua mempunyai fobia demam. Orang tua mengira bahwa bila tidak diobati, demam anaknya akan semakin tinggi. Kepercayaan tersebut tidak terbukti berdasarkan fakta. Karena konsep yang salah ini banyak orang tua mengobati demam ringan yang sebetulnya tidak perlu diobati.

Penanganan demam pada anak balita di rumah memerlukan pendekatan yang tepat dan aman untuk memastikan kesehatan dan kenyamanan anak. Berdasarkan rekomendasi medis, World Health Organization (WHO), American Academy of Pediatrics (AAP), dan hasil penelitian empiris, berikut adalah panduan manajemen penanganan demam yang tepat di rumah, yang mencakup deteksi demam, penanganan farmakologi, dan penanganan non-farmakologi: (R. Green et al., 2021; National Institute For Health and Care Excellence, 2021)

Penatalaksanaan demam pada anak bertujuan untuk mengurangi ketidaknyamanan, menjaga kestabilan suhu tubuh, dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Demam pada umumnya adalah respons fisiologis tubuh terhadap infeksi atau peradangan dan sering kali dapat dikelola dengan pendekatan yang tepat di rumah.

Upaya penanganan demam pada anak di rumah (*Home Fever remedies*) meliputi: (R. Green et al., 2021; Kurniawati et al., 2021; National Institute For Health and Care Excellence, 2021)

1. Deteksi Demam Anak

Deteksi demam pada anak merupakan hal yang penting dan harus dilakukan dengan segera, hal ini karena demam dapat menandakan adanya infeksi atau inflamasi yang sedang terjadi di dalam tubuh anak.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam mendeteksi demam anak yaitu:

a. Alat deteksi demam dan cara penggunaan

1) Termometer digital

Termometer digital adalah jenis termometer yang paling umum dan populer digunakan. Untuk mengukur suhu tubuh, kita hanya perlu

menghidupkan *power* dan memasukkannya ke lubang telinga atau di axilla, termometer akan mengukur suhu dan menampilkannya pada layar digital dalam beberapa saat. Pastikan untuk membersihkan termometer setelah digunakan dan menjaga sterilitas untuk mencegah penyebaran infeksi.



Gambar 2.1 Termometer Digital

2) Termometer Infrared

Termometer infrared bekerja dengan mendeteksi panas yang dikeluarkan oleh tubuh melalui sinar infra merah. Hidupkan power, arahkan termometer pada bagian tubuh yang akan diukur seperti lubang telinga atau dahi, dan tunggu beberapa saat hingga menampilkan hasil. Termometer infrared mudah digunakan dan cepat dalam mengukur suhu tubuh.



Gambar 2.2 Termometer Infrared

3) Termometer Galil

Termometer galil yaitu termometer berisi mercury atau alkohol berbentuk silinder transparan yang terdapat skala suhu. Termometer ini harus ditempatkan pada bagian tubuh yang akan diukur minimal selama 3 menit. Setelah itu, baca skala pada silinder transparan untuk mengetahui suhu tubuh. Namun, termometer galil sudah tidak banyak digunakan karena risiko pecah dan cairan mercury berdampak negatif pada lingkungan.



Gambar 2.3 Termometer Galil

4) Termometer Striping.

Termometer striping bekerja dengan cara mengukur suhu tubuh dengan menggunakan sensor pada bagian tepi. Cara penggunaan: tempelkan striping pada bagian tubuh yang akan diukur. Striping akan mengubah warna sesuai dengan suhu yang terukur. Namun, termometer striping hanya dapat digunakan sekali dan harus diganti setiap kali digunakan.



Gambar 2.4 Termometer Striping

b. Pengukuran suhu rutin/ berkala

- 1) Lakukan pengukuran suhu tubuh secara rutin, terutama jika anak menunjukkan tanda-tanda tidak sehat seperti rewel, lesu, atau nafsu makan menurun.
- 2) Suhu tubuh normal untuk bayi dan balita biasanya berkisar antara $36,5^{\circ}\text{C}$ hingga $37,5^{\circ}\text{C}$.
- 3) Perhatikan gejala lain. Jika anak tampak lebih rewel atau lesu daripada biasanya, hal ini bisa menjadi indikasi awal demam. Amati juga gejala lain yang mungkin menyertai demam, seperti keringat berlebih, kulit kemerahan, atau napas cepat.
- 4) Jika suhu tubuh anak $> 37,5^{\circ}\text{C}$, lakukan pengukuran suhu berkala setiap 20-30 menit.

c. Deteksi demam anak tanpa alat

Cara mendeteksi demam ini dengan perabaan taktil tanpa menggunakan alat yaitu dengan menggunakan sentuhan tangan yang sudah dicuci bersih dan kering. Tangan diletakkan pada permukaan kulit anak terutama pada bagian dahi, paha, dada atau abdomen. Namun cara ini hanya dapat menunjukkan tanda atau gejala awal demam, tetapi tidak akan menunjukkan angka suhu yang tepat. Perabaan taktil dapat bersifat subyektif dan dapat terpengaruh oleh faktor-faktor lain, seperti keadaan lingkungan atau kondisi tangan yang memberi sentuhan. Selain perabaan taktil, perhatikan juga kondisi lain pada anak seperti sianosis, tachycardia, tachypnoea, turgor kulit, ekstremitas dingin, *poor capillary refill* (> 3 detik), kemerahan pada kulit, tanda dehidrasi (ubun-ubun cekung, mulut kering, mata cekung, turgor buruk).

2. Penanganan demam secara Non-farmakologi

a. Pendinginan fisik dengan kompres hangat.

Kompres hangat adalah teknik pendinginan yang dilakukan dengan menggunakan kain atau sediaan lain yang dipanaskan dan kemudian ditempel di atas kulit tubuh bagian yang memerlukan pendinginan.

Prosedur pemberian kompres hangat:

Siapkan air hangat dengan suhu sekitar 37-40 derajat Celsius.

- 1) Gunakan kain bersih atau handuk kecil yang dapat menyerap air dengan baik.
- 2) Celupkan kain atau handuk ke dalam air hangat, kemudian peras
- 3) hingga kain tidak terlalu basah.

- 4) Letakkan kompres hangat pada area dahi, leher, ketiak, atau lipatan paha anak.
- 5) Ganti kompres setiap 10-15 menit atau ketika kain mulai mendingin.
- 6) Lanjutkan prosedur ini selama 30-60 menit sesuai kebutuhan dan respons anak terhadap kompres.

Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian kompres hangat yaitu dapat menyebabkan iritasi kulit dan ketidaknyamanan jika digunakan terlalu lama serta tidak boleh diaplikasikan pada bagian kulit yang luka atau terbakar.

b. Pendinginan fisik dengan kompres dingin

Kompres dingin adalah teknik pendinginan yang dilakukan dengan menggunakan kain atau sediaan lain yang dingin dan kemudian ditempel di atas kulit tubuh bagian yang memerlukan pendinginan.

Prosedur pemberian kompres dingin yaitu:

- 1) Siapkan air dingin atau air yang dicampur dengan es dalam mangkuk.
- 2) Gunakan kain bersih atau handuk kecil yang mudah menyerap air.
- 3) Celupkan kain atau handuk ke dalam air dingin, kemudian peras hingga kain tidak terlalu basah.
- 4) Letakkan kompres dingin pada area dahi, leher, ketiak, atau lipatan paha anak.
- 5) Ganti kompres setiap 10-15 menit atau ketika kain mulai menghangat.
- 6) Lanjutkan prosedur ini selama 30-60 menit sesuai kebutuhan dan respons anak terhadap kompres.

Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian kompres dingin yaitu tidak boleh dilakukan terlalu lama karena dapat menyebabkan anak menggigil dan hhipotermia

- c. Penanganan demam dengan pemberian cairan oral (R. Green et al., 2021).

Penanganan demam pada balita di rumah dapat dilakukan dengan pemberian cairan oral yang adekuat yaitu minuman yang mudah dicerna oleh tubuh dan tidak menimbulkan efek samping negatif pada anak seperti air mineral, susu dan air kelapa. Untuk bayi bawah dua tahun harus tetap diberikan ASI. Manfaat dari pemberian cairan oral yang adekuat adalah untuk menggantikan cairan yang hilang dari tubuh anak karena demam.

Cara pemberian cairan oral yaitu:

- 1) Istirahatkan anak di ruangan dengan ambient temperature 20-23°C dengan ventilasi yang baik.
- 2) Kenakan pakaian tipis dan ringan
- 3) Siapkan air minum hangat
- 4) Berikan minuman pada anak, dapat menggunakan sendok, gelas atau botol untuk memberikan cairan ke mulut anak.
- 5) Selain air mineral, jenis cairan lain yang dapat diberikan yaitu jus buah, electrolyte solution, air beras dan susu.
- 6) Berikan cairan dalam jumlah cukup 50-80 ml/kg atau 10 cc/kg/°C peningkatan temperatur; diberikan secara bertahap dalam jumlah cukup dan frekuensi sering pada interval waktu sekitar 45-60 menit.
- 7) Bantu anak untuk tidak menahan buang air kecil



Gambar 2.5 Pemberian Cairan Oral Adekuat Pada Anak Demam

Hal yang harus diperhatikan pada pemberian cairan oral yaitu, tidak boleh memberi cairan berlebihan dan interval yang singkat karena dapat menyebabkan mual, muntah, pusing dan berkurangnya nafsu makan.

d. Pemberian nutrisi yang adekuat

Pada kondisi demam biasanya anak akan mengalami kelelahan dan kehilangan nafsu makan. Anak demam tetap perlu mendapatkan makanan/nutrisi yang adekuat.

- 1) Berikan makanan ringan dan mudah dicerna seperti bubur, sup, atau oatmeal.
- 2) Berikan makanan yang kaya protein dan vitamin seperti daging, telur, hati
- 3) Berikan makanan yang kaya akan vitamin dan mineral, seperti sayuran dan buah

Disarankan untuk tidak memberikan makanan yang dapat memicu mual atau muntah; tidak memaksa anak untuk makan; berikan makanan jika anak merasa lapar;

beri makanan dengan porsi kecil dengan frekuensi sering



Gambar 2.6 Pemberian Nutrisi Adekuat Pada Anak Demam

3. Penanganan demam secara farmakologi

Antipiretik adalah obat-obat yang digunakan untuk mengurangi gejala demam yang bekerja dengan cara mengurangi produksi prostaglandin, molekul yang memicu demam. Dianjurkan untuk memberikan antipiretik jika suhu tubuh anak $>39^{\circ}\text{C}$ dan bukan semata hanya untuk menurunkan demam. Antipiretik diberikan jika anak menunjukkan gejala demam yang signifikan dan ketidaknyamanan.

Beberapa jenis antipiretik yang sering digunakan dalam pengobatan demam adalah:

- a. Ibuprofen: Ibuprofen adalah obat antipiretik yang sering digunakan untuk mengurangi gejala demam. Dosis umum adalah 5-10 mg/kg setiap 6-8 jam, dan tidak boleh melebihi dosis maksimum harian 40 mg/kg. Penggunaannya harus dengan saran dokter terutama pada anak-anak dengan kondisi medis tertentu terutama masalah ginjal.

- b. Paracetamol: adalah obat yang umum digunakan dan aman untuk bayi dan balita. Dosis umum adalah 10-15 mg/kg setiap 4-6 jam sesuai kebutuhan dan tidak boleh melebihi dosis maksimum harian 60 mg/kg. Pastikan untuk selalu membaca label obat dan mengikuti instruksi dari dokter atau apoteker.

Hal penting untuk diperhatikan yaitu antipiretik harus diberikan sesuai dengan dosis dan interval waktu yang tepat. Overdosis antipiretik dapat menyebabkan efek samping serius, seperti kerusakan hati atau ginjal. Antipiretik biasanya hanya diberikan jika demam tidak menurun atau jika demam menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan bagi anak. Selain itu, tidak boleh mengonsumsi lebih dari satu jenis obat antipiretik dalam waktu yang sama.

Secara umum, penanganan demam secara farmakologis dengan menggunakan antipiretik hanya digunakan jika demam tidak dapat dikontrol dengan cara non-farmakologis, seperti memberi banyak minum dan mengenakan pakaian tipis dan ringan.

Adapun jenis antipiretik dan cara penggunaannya terdiri dari:

- a. Syrup/Cairan: Bentuk yang paling umum untuk bayi dan balita karena mudah diberikan dan dosis dapat diukur dengan akurat.
- b. Suppositoria: Alternatif bagi anak-anak yang mengalami muntah atau kesulitan menelan obat.
- c. Tablet Kunyah: Cocok untuk anak yang lebih besar yang dapat mengunyah tablet.

I. Pemantauan dan Tindakan Lanjut

Setelah penatalaksanaan demam dilakukan, penting untuk memantau kondisi anak secara berkala. Pemantauan ini meliputi pengukuran suhu tubuh dan observasi terhadap perubahan kondisi anak.

1. Pantau suhu tubuh anak secara berkala untuk memastikan bahwa demam turun dan tidak ada gejala tambahan yang muncul.
2. Berikan antipiretik sesuai jadwal yang direkomendasikan, dan hindari pemberian dosis yang berlebihan.
3. Jika demam tidak turun dalam waktu 24-48 jam atau jika muncul gejala lain yang mengkhawatirkan, segera bawa anak ke pelayanan kesehatan.
4. Jika mendapat rekomendasi medis untuk memberikan antibiotik pada anak, pantau reaksi tubuh anak terhadap antibiotik tersebut; termasuk perbaikan gejala atau jika ada efek samping seperti diare, ruam atau reaksi alergi; Selesaikan seluruh rangkaian antibiotik meskipun gejala demam sudah membaik.
5. Penanganan demam pada bayi dan balita di rumah harus dilakukan berdasarkan panduan medis yang tepat.
6. Deteksi dini, penggunaan antipiretik dan antibiotik yang tepat, serta pendinginan fisik yang aman dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan anak dan mencegah komplikasi.
7. Edukasi orang tua

Penting untuk memberikan edukasi kepada orang tua mengenai cara yang tepat dalam menangani demam di rumah. Orang tua perlu memahami bahwa demam sendiri bukanlah penyakit yang berbahaya, tetapi bisa menjadi gejala dari kondisi yang lebih serius yang memerlukan perhatian medis. Edukasi ini termasuk cara yang tepat

untuk memberikan cairan, pengukuran suhu tubuh, penggunaan antipiretik, dan kapan harus mencari pertolongan medis lebih lanjut (R. Green et al., 2021).

BAB 3

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENANGANAN DEMAM ANAK DI RUMAH

A. Teori Lawrence Green dan Faktor yang Mempengaruhi Penanganan Demam

Penanganan demam di rumah (*Home Fever Remedies/ HFR*) merupakan salah satu perilaku kesehatan masyarakat. Lawrence Green adalah salah satu ahli kesehatan masyarakat yang memformulasikan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat. Salah satu teori nya dikenal dengan nama PRECEDE model (*Predisposing, Reinforcing, and Enabling Constructs in Educational Diagnosis and Evaluation*).

Setiap individu memiliki perilakunya sendiri yang berbeda dengan individu lain, termasuk pada kembar identik sekalipun. Perilaku tidak selalu mengikuti urutan tertentu sehingga terbentuknya perilaku positif tidak selalu dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap positif. Berkaitan dengan determinan faktor HFR yang diintegrasikan dengan model L.Green ini (L. W. Green & Glasgow, 2006), terdapat 3 faktor utama HFR yaitu faktor *predisposing*, *enabling* dan *reinforcing*.

B. Faktor *Predisposing*

Faktor *predisposing* merupakan faktor yang menjadi dasar motivasi atau niat seseorang melakukan sesuatu. Faktor

pendorong meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai dan persepsi, tradisi, dan unsur lain yang terdapat dalam diri individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan.

Faktor predisposing yang menjadi pemicu perilaku kesehatan HFR yaitu:

a. Usia

Seiring bertambahnya usia seseorang, kondisi fisik dan mentalnya akan semakin meningkat. Semakin bertambah umur, tingkat kedewasaan akan lebih matang dalam berfikir, bertindak dan mengambil keputusan (Silviyana et al., 2022). usia berkorelasi positif dengan pengalaman hidup seseorang, termasuk pengalaman orang tua dalam menjaga kesehatan anak (Suryagustina et al., 2022). Semakin bertambah usia semakin baik peran orang tua dalam memberi penanganan demam anak (Andari et al., 2022). Usia orang tua dapat mempengaruhi kepribadian mereka dalam pola asuh anak. Seperti misalnya orang tua muda memiliki energi prima untuk mengurus anak namun memiliki kecenderungan depresi. Sementara itu, orang tua berusia matang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak (Andari et al., 2022).

b. Jenis Kelamin

Wanita lebih banyak menggunakan otak kanan daripada pria, itulah sebabnya mereka lebih mampu melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang dan menarik kesimpulan. Selain itu, otak wanita lebih mampu mengasosiasikan ingatan dan situasi sosial, itulah sebabnya mereka lebih mengandalkan perasaan daripada pria. Wanita dapat menyerap informasi lima kali lebih cepat daripada pria. Inilah alasan mengapa wanita lebih cepat menyimpulkan sesuatu daripada pria. Berbeda dengan wanita, pria

memiliki keterampilan motorik yang lebih kuat daripada wanita, yang membuat mereka lebih baik dalam aktivitas yang membutuhkan koordinasi tangan-mata yang baik (Istiyati, S.; Nuzuliana, R.; Shalihah, 2020).

Dalam hal perbedaan gender orang tua yaitu ibu dan ayah, hasil penelitian menunjukkan meskipun secara umum tidak terdapat perbedaan *home fever management* yang dilakukan namun ibu menunjukkan ketelitian yang lebih baik dalam menyiapkan dosis obat (Fadilla & Gayatri, 2022). Selain hal tersebut, meski adat timur menunjukkan dominasi peran ibu dalam pengasuhan anak, namun saat ini harmonisasi gender dalam pengasuhan anak di keluarga mulai dibudayakan (Istiyati, S.; Nuzuliana, R.; Shalihah, 2020).

C. Status perkawinan/ keberadaan pasangan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Ukuran otak seseorang tidak memengaruhi kecerdasan atau IQ mereka. Selain itu, otak pria mengalami perubahan seksual yang dipengaruhi oleh hormon testosteron. Sementara otak pria biasanya lebih besar dari wanita, hippocampus pada wanita lebih besar dari pada pria. Ini berarti wanita dapat memproses informasi lebih cepat daripada pria. Hippocampus merupakan bagian otak yang menyimpan memori, hal ini menjadi alasan wanita mampu mengolah informasi yang lebih cepat daripada pria (Fadilla & Gayatri, 2022).

Terkait dengan status pernikahan orang tua, meski dilaporkan bahwa tidak ada pengaruh langsung status

pernikahan dengan penanganan demam anak (Sakr et al., 2022), namun studi empiris membuktikan bahwa status pernikahan atau keberadaan pasangan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik dan mental anak (Tian et al., 2023). Anak dengan orang tua tunggal karena bercerai akan mengalami konflik dalam interaksi dan pola pengasuhan. Di samping itu anak dengan dengan orang tua tunggal karena meninggal akan kurang perhatian, kesulitan ekonomi dan kurang akses ke pelayanan kesehatan. Keluarga dengan orang tua utuh, pola komunikasi dan interaksi yang sehat dan seimbang akan berpengaruh positif pada pola pengasuhan, tumbuh kembang anak dan pengambilan keputusan terkait kesehatan (Istiyati, S.; Nuzuliana, R.; Shalihah, 2020)

D. Pendidikan

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku akan pola hidup, semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin mudah dalam menerima informasi. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi pengetahuan seseorang untuk berperilaku dalam masalah kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua maka semakin baik self management demam yang dilakukan, dan semakin baik dalam penanganan demam pada anak (Setiani et al., 2022).

Tingkat pendidikan mempengaruhi pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya arti kesehatan baik diri sendiri maupun pada lingkungannya, terutama dalam mengambil keputusan yang baik khususnya yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan pada anak (Puspitosari & Hartono, 2022).

Teori self-efficacy, yang diperkenalkan oleh Albert Bandura pada tahun 1977, mengacu pada keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan yang

diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Self-efficacy bukan hanya tentang kemampuan fisik, tetapi juga mencakup keyakinan psikologis dan keterampilan dalam menghadapi tantangan. Self-efficacy berperan penting dalam menciptakan perilaku sehat. Individu yang memiliki tingkat self-efficacy yang tinggi cenderung lebih percaya diri untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga Kesehatan. Pengetahuan tentang kesehatan sering kali tidak cukup untuk mendorong perilaku sehat. Pengetahuan tersebut perlu disertai dengan keyakinan diri untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengembangan self-efficacy menjadi sangat penting dalam program-program promosi kesehatan dan intervensi.

E. Pekerjaan dan Pendapatan

Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka mencari nafkah, baik melalui mendapatkan gaji (*salary*) atau melalui melakukan kegiatan yang mengurus kebutuhan mereka. Lingkungan kerja dapat membuat seseorang belajar dan mengalami berbagai hal secara langsung maupun tidak langsung. Terkadang pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi individu lain untuk belajar atau bisa juga aktivitas pekerjaan yang dilakukannya justru membuat individu tersebut tidak dapat mengakses informasi.

Orang tua yang bekerja dan memperoleh penghasilan yang baik lebih memungkinkan untuk menggunakan media sosial dan jejaring sosial dalam mencari informasi penanganan demam di rumah dan mempunyai akses yang lebih baik ke fasilitas pelayanan kesehatan (Puspitosari & Hartono, 2022).

Orang tua yang bekerja di luar rumah cenderung mempunyai waktu yang sedikit untuk bersama anaknya, di

bandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. ibu rumah tangga tentunya mempunyai kesempatan lebih banyak dalam mengurus rumah tangga termasuk dalam menangani anak yang menderita demam di rumah (Setiani et al., 2022). Pendapatan keluarga dapat mempengaruhi kesehatan anak, seperti halnya ketika anak demam dan mengharuskan membeli obat maka pendapatan keluarga inilah yang dikeluarkan. Maka dari itu pendapatan keluarga perlu ditingkatkan agar memungkinkan orangtua dapat menyediakan jaminan kesehatan serta sarana prasarana yang menunjang kesehatan anak (Banjarnahor et al., 2015)

F. Pengetahuan

Pengetahuan orang tua sangat menunjang dalam penatalaksanaan demam pada anak. Pengetahuan merupakan domain paling penting bagi terbentuknya suatu tindakan dan perilaku pada diri manusia. Ibu yang memiliki pengetahuan tentang demam dan memiliki sikap yang baik maka dalam memberikan perawatan dapat menentukan pengelolaan demam yang terbaik bagi anaknya serta mampu mengidentifikasi gejala dan komplikasi akibat demam seperti, dehidrasi dan kejang demam (Fibritiani et al., 2023). Tingkat pengetahuan orang tua tersebut salah satunya di latar belakang oleh pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maka akan menyebabkan ibu menjadi panik dan gelisah ketika anaknya mengalami demam (Sudibyo et al., 2020).

G. Sikap

Sikap adalah suatu persepsi, preferensi, atau kebiasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Sikap dapat mempengaruhi tindakan, penafsiran, atau reaksi seseorang terhadap situasi tertentu. Menurut Albarracin (2014) dalam

(Swarjana, 2022) sikap didefinisikan sebagai kecenderungan psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi entitas dalam beberapa *grade* atau tingkatan. Sikap juga didefinisikan sebagai reaksi atau kecenderungan seseorang dalam merespons objek, orang, konsep, atau situasi dengan cara tertentu, yang didasarkan pada evaluasi positif atau negatif.

Sikap positif (*good attitude*) yang dimiliki orang tua terhadap HFR sangat penting dalam manajemen demam pada anak. Sikap ini tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat tetapi juga memberikan dukungan emosional kepada anak yang sedang sakit. Berikut adalah beberapa sikap positif yang sebaiknya dimiliki orang tua dalam menangani demam pada anak: (Hamideh Kerdar et al., 2021; Walsh, 2007; Wayan et al., 2022)

1. Tenang dan Rasional:

Orang tua perlu tetap tenang dan tidak panik saat anak mengalami demam. Sikap tenang membantu dalam pengambilan keputusan yang rasional dan menghindari tindakan yang berlebihan. Menurut hasil studi bahwa orang tua yang tenang lebih efektif dalam mengikuti instruksi medis dan memberikan perawatan yang tepat.

2. Terbuka terhadap Informasi:

Orang tua harus terbuka terhadap informasi dan edukasi mengenai penanganan demam, termasuk memahami gejala, pengobatan, dan kapan harus mencari bantuan medis. Orang tua yang terbuka terhadap informasi lebih cenderung mengikuti pedoman medis yang benar

3. Proaktif dalam Edukasi Kesehatan:

Orang tua yang proaktif dalam mencari pengetahuan tentang kesehatan anak akan cenderung lebih siap dalam menangani demam. Hal ini dapat dilakukan dengan

membaca literatur, menghadiri penyuluhan kesehatan, atau berkonsultasi dengan tenaga medis.

4. Penuh Perhatian dan Empati:

Menunjukkan perhatian dan empati kepada anak yang sedang demam sangat penting, hal ini membantu anak merasa nyaman dan aman, yang dapat mempercepat pemulihan.

5. Patuh terhadap Instruksi Medis:

Kepatuhan terhadap instruksi medis, seperti dosis obat antipiretik yang tepat dan mengikuti jadwal pemberian obat, sangat penting dalam manajemen demam yang efektif.

6. Sabar dan Penuh Pengertian:

Kesabaran dan pengertian dalam merawat anak yang demam membantu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pemulihan anak. Menghindari tindakan yang terburu-buru dan memberikan waktu yang cukup untuk anak istirahat.

7. Komunikatif dan Transparan:

Selayaknya orang tua harus bersikap komunikatif dan transparan dengan tenaga medis. Memberikan informasi yang akurat tentang gejala dan riwayat kesehatan anak sangat penting untuk diagnosis dan penanganan yang tepat.

H. Faktor enabling (Faktor Pemungkin)

Faktor enabling merupakan faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. Faktor pemungkin meliputi sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan. Untuk berperilaku sehat, masyarakat memerlukan sarana dan prasarana pendukung, seperti puskesmas, rumah sakit,

posyandu, dokter atau bidan praktik, dan juga mencari informasi melalui media massa seperti media internet, media cetak, media elektronik, dan media sosial

I. Faktor Reinforcing (Faktor Pendorong)

Faktor reinforcing merupakan faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku seseorang yang dikarenakan adanya dukungan keluarga, sikap suami, orang tua, tokoh masyarakat atau petugas kesehatan

a. Dukungan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh individu dalam proses sosialisasinya. Dukungan keluarga merupakan bantuan yang diberikan kepada keluarga berupa barang, jasa, informasi, dan nasehat. Dalam hal penanganan demam, orang tua/ *caregiver* yang memberi perawatan pada anak, perlu mendapat dukungan positif dari anggota keluarga yang lain (Nakahara et al., 2010). Hal ini akan berpengaruh positif pada seluruh keluarga terutama pada anak yang sakit dan dapat berpengaruh pada percepatan proses penyembuhan. Berikut adalah bentuk dukungan keluarga (Friedman et al., 2003):

1) Dukungan informasional

Dukungan ini meliputi jaringan komunikasi dan tanggung jawab bersama, termasuk memberikan solusi dari masalah, memberikan nasehat, pengarahan, saran ataupun umpan balik tentang apa yang dilakukan. Bentuk dari dukungan ini dapat berupa pemberian arahan dan dorongan semangat yang diberikan dari pihak keluarga.

2) Dukungan Instrumental

Dukungan ini merupakan sebuah pertolongan praktis dalam hal kebutuhan hidup yang meliputi penyediaan

dukungan, seperti halnya bantuan finansial dan material secara langsung yang diberikan oleh keluarga

3) Dukungan Penilaian

Dukungan penilaian merupakan penghargaan yang bersifat positif dapat berupa dorongan dan arahan bimbingan sebagai umpan balik. Keluarga memberikan bimbingan dan menengahi sebuah permasalahan yang sedang dihadapi anggota keluarga diantaranya memberikan support, penghargaan, dan perhatian.

4) Dukungan Emosional

Dukungan ini berasal dari keluarga sebagai tempat yang nyaman, dukungan emosional mencakup ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian terhadap individu sehingga individu tersebut merasa nyaman, dicintai, dan diperhatikan.

Adanya dukungan dari anggota keluarga lain untuk membantu dalam perawatan anak yang demam dapat meringankan beban orang tua dan memastikan anak mendapatkan perhatian yang diperlukan.

b. Peran Petugas Kesehatan

Petugas kesehatan terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas, berperan penting dalam optimalisasi penanganan demam oleh orangtua di rumah. Petugas kesehatan berperan sebagai jembatan antara fasilitas kesehatan dan masyarakat, memberikan edukasi, arahan dan dukungan kepada keluarga dan anak yang demam

Peran tenaga Kesehatan di komunitas dalam HFR yaitu:

1) Penyuluhan tentang penanganan demam:

Tenaga kesehatan di komunitas bertanggung jawab memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang cara yang tepat untuk menangani demam pada anak di

rumah. Hal ini termasuk informasi tentang penggunaan obat antipiretik, metode non-farmakologi, dan tanda-tanda bahaya yang memerlukan perhatian medis.

2) Pemantauan dan evaluasi kesehatan anak

Tenaga kesehatan di komunitas melakukan kunjungan rumah untuk memantau kesehatan anak-anak yang mengalami demam, mengukur suhu tubuh, memeriksa gejala lain yang menyertai demam, dan mengevaluasi kondisi umum anak serta deteksi dini komplikasi yang mungkin timbul akibat demam.

3) Pemberian Obat dan Perawatan Non-Farmakologi

Tenaga kesehatan di komunitas memberikan panduan tentang penggunaan obat antipiretik yang aman dan efektif. Perawat juga mengajarkan cara menerapkan kompres hangat/ dingin yang tepat dalam menurunkan demam

4) Konseling dan dukungan psikologis

Tenaga kesehatan di komunitas memberikan dukungan psikologis kepada orang tua yang cemas tentang kondisi anak yang demam. Perawat membantu mengurangi kecemasan dengan memberikan informasi yang jelas dan menenangkan. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap perawatan kesehatan

5) Rujukan dan akses ke fasilitas kesehatan

Jika ditemukan tanda-tanda bahaya atau kondisi yang memerlukan perhatian medis lebih lanjut, perawat komunitas bertanggung jawab untuk merujuk anak ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap untuk mencegah komplikasi serius akibat demam

- 6) Penyediaan Informasi dan Sumber Daya
Tenaga kesehatan di komunitas menyediakan materi edukasi seperti brosur dan pamflet yang berisi informasi tentang penanganan demam.
- 7) Kolaborasi Interprofesional
Tenaga kesehatan di komunitas berkolaborasi dengan tim medis lainnya untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang holistik dan terkoordinasi kepada keluarga dan anak penderita demam. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perawatan dan kesehatan anak.
- 8) Program edukasi kesehatan berkelanjutan
Tenaga kesehatan di komunitas terlibat dalam program edukasi berkelanjutan yang memastikan orang tua tetap mendapatkan informasi *update* tentang penanganan demam dan kesehatan anak secara umum
- 9) Program preventif dan promotif
Tenaga kesehatan berperan dalam upaya pencegahan penyakit dengan mengajarkan praktik kebersihan yang baik dan pentingnya vaksinasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi insiden penyakit infeksi yang dapat menyebabkan demam.
- 10) Pemberdayaan Keluarga
Tenaga kesehatan di komunitas membantu memberdayakan orang tua dan keluarga dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kemandirian keluarga dalam merawat anak demam di rumah.
- 11) Pemantauan Kesehatan Berkala
Tenaga kesehatan di komunitas melakukan pemantauan kesehatan secara berkala untuk memastikan bahwa anak-anak yang pernah mengalami

demam tetap dalam kondisi sehat dan tidak mengalami komplikasi jangka panjang

12) Penanganan komplikasi

Jika terjadi komplikasi seperti dehidrasi atau kejang demam, tim medis memberikan penatalaksanaan yang tepat. Intervensi awal terhadap komplikasi demam meningkatkan peluang pemulihan cepat dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

13) Promosi Kesehatan di Komunitas

Program promosi kesehatan di tingkat komunitas bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, skill dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan demam yang tepat dan kesehatan anak secara umum.

BAB 4

MODEL PREDIKSI PENANGANAN DEMAM ANAK DI RUMAH

Demam adalah kondisi yang umum terjadi pada anak dan sering kali menjadi perhatian utama bagi orang tua. Penanganan demam pada anak di rumah bergantung pada berbagai faktor, termasuk pengetahuan, sikap, akses terhadap layanan kesehatan, dan kondisi sosial-ekonomi. Perbedaan mendasar antara negara maju dan berkembang terlihat dari cara masyarakat menangani kondisi ini. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan memberikan dampak signifikan terhadap keputusan orang tua dalam merawat anak yang mengalami demam.

Literasi kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi penanganan demam. Di negara maju, tingkat literasi kesehatan yang lebih tinggi memungkinkan orang tua untuk memahami langkah-langkah yang tepat dalam menangani demam. Studi menunjukkan bahwa orang tua di negara maju cenderung lebih memahami bahwa demam bukan penyakit, melainkan gejala dari suatu kondisi mendasar yang perlu diidentifikasi (Dabis et al., 2002; Watt et al., 2010). Sebaliknya, di negara berkembang, rendahnya tingkat literasi kesehatan sering kali menyebabkan kesalahpahaman tentang demam, seperti anggapan bahwa semua demam harus segera diobati dengan antipiretik tanpa mempertimbangkan penyebabnya (Ogunyinka et al., 2023).

Akses terhadap informasi juga memainkan peran penting. Di negara maju, informasi mengenai penanganan

demam tersedia secara luas melalui sumber terpercaya seperti aplikasi kesehatan, layanan telekonsultasi, atau situs web yang dikelola oleh lembaga kesehatan resmi (NICE guidelines, 2013; Ogunyinka et al., 2023). Sebaliknya, di negara berkembang, informasi yang diterima orang tua sering kali berasal dari sumber tidak resmi, seperti tetangga atau media sosial, yang dapat memberikan informasi keliru (Dabis et al., 2002). Faktor ekonomi menjadi salah satu pembeda yang signifikan. Di negara maju, sistem asuransi kesehatan yang baik memungkinkan orang tua untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa beban biaya yang besar. Hal ini memungkinkan mereka untuk segera berkonsultasi dengan dokter jika diperlukan (Tchamo et al., 2022). Sebaliknya, di negara berkembang, keterbatasan finansial sering kali membuat orang tua menunda perawatan atau menggunakan cara tradisional yang kurang efektif dan berpotensi membahayakan anak (Arias et al., 2019).

Sikap terhadap pengobatan modern dan tradisional juga bervariasi. Di negara maju, orang tua lebih cenderung menggunakan antipiretik sesuai dosis yang dianjurkan dan memastikan anak tetap terhidrasi dengan baik. Mereka juga memahami pentingnya memantau gejala tambahan seperti kejang demam atau tanda dehidrasi berat (Arthur, 2014). Di negara berkembang, penggunaan obat tradisional atau metode alternatif, seperti mengoleskan ramuan herbal, masih menjadi praktik umum. Hal ini sering kali dilakukan karena keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan atau karena pengaruh budaya setempat (Betz, 2005).

Faktor geografis dan ketersediaan fasilitas kesehatan juga memengaruhi penanganan demam. Di negara maju, layanan kesehatan seperti klinik darurat atau pusat kesehatan tersedia secara luas, bahkan di daerah pedesaan.

Hal ini memudahkan orang tua untuk mendapatkan bantuan medis jika diperlukan (Perez et al., 2009). Sebaliknya, di negara berkembang, banyak wilayah terpencil yang tidak memiliki fasilitas kesehatan, sehingga orang tua harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan (Park et al., 2024).

Budaya dan norma sosial turut membentuk cara orang tua menangani demam. Di beberapa negara berkembang, ada keyakinan bahwa demam adalah bagian dari proses penyembuhan alami tubuh, sehingga tidak perlu ditangani kecuali sudah parah. Di sisi lain, di negara maju, orang tua cenderung lebih responsif terhadap tanda-tanda awal penyakit dan mengambil tindakan preventif lebih awal (Agrawal et al., 2023).

Sumber daya manusia dalam bidang kesehatan, seperti jumlah tenaga medis yang tersedia, juga memengaruhi bagaimana masyarakat menangani demam. Negara maju umumnya memiliki rasio dokter dan perawat yang lebih tinggi dibandingkan negara berkembang, sehingga orang tua memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan edukasi kesehatan secara langsung (Beerenbrock et al., 2024).

Tingkat pendidikan formal orang tua juga memiliki dampak signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua dengan pendidikan yang lebih tinggi lebih mampu memahami instruksi medis dan mengambil keputusan yang tepat mengenai perawatan anak mereka (Urbane et al., 2019; Yuniati et al., 2025). Sebaliknya, di negara berkembang, tingkat pendidikan yang lebih rendah sering kali menjadi penghalang dalam memahami pentingnya penanganan demam yang benar.

Selain itu, pekerjaan orang tua memengaruhi perhatian yang dapat diberikan kepada anak yang sakit. Orang tua yang bekerja penuh waktu di negara maju sering kali mengandalkan layanan seperti telekonsultasi untuk mendapatkan saran medis tanpa harus meninggalkan pekerjaan mereka (Dabis et al., 2002). Sebaliknya, di negara berkembang, orang tua yang bekerja di sektor informal sering kali menghadapi dilema antara mencari nafkah dan merawat anak mereka yang sedang demam (Tchamo et al., 2022).

Kemajuan teknologi di negara maju telah memungkinkan pengembangan alat bantu diagnostik yang dapat digunakan di rumah, seperti termometer digital atau aplikasi untuk memantau gejala demam (Tavan et al., 2022). Namun, di negara berkembang, teknologi seperti ini belum dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat, terutama di daerah pedesaan (Agustiawan et al., 2022). Program pendidikan kesehatan yang terstruktur juga menjadi faktor penting. Di negara maju, edukasi tentang penanganan demam biasanya dimulai sejak dini, baik melalui sekolah maupun kampanye kesehatan publik. Hal ini membantu orang tua memahami kapan mereka perlu membawa anak ke dokter dan kapan cukup dirawat di rumah (Yuniati et al., 2025). Di negara berkembang, program pendidikan semacam ini sering kali tidak tersedia secara luas karena keterbatasan sumber daya (Urbane et al., 2019). Terlepas dari perbedaan yang ada, ada kebutuhan mendesak meningkatkan literasi kesehatan di negara berkembang. Kampanye kesehatan berbasis komunitas dan penggunaan teknologi sederhana, seperti pesan teks atau video edukasi, dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan ini.

Hasil penelitian ini diperoleh data bahwa Puskesmas 4 Ulu Palembang telah melaksanakan program pelayanan kesehatan anak yang dilakukan secara intensif, terutama dalam menangani kasus demam pada anak. Pelayanan kesehatan anak ini tersedia di Poli Kesehatan Ibu dan Anak serta di Posyandu Balita. Di kedua tempat ini, orang tua dan anak dapat memperoleh pelayanan berupa konsultasi medis, edukasi terkait penanganan demam pada anak, serta pemberian obat-obatan farmakologi yang sesuai dengan kondisi anak. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan komprehensif bagi anak-anak yang mengalami demam, dengan tujuan menurunkan tingkat kecemasan orang tua dan memastikan anak mendapatkan penanganan yang tepat. Meski demikian, pelayanan penanganan demam pada anak di Puskesmas 4 Ulu Palembang saat ini masih bersifat individual dan situasional. Pelayanan kesehatan baru diberikan ketika ada pasien anak yang berkunjung dengan keluhan demam, sehingga belum terdapat tindakan pencegahan atau edukasi rutin yang bersifat proaktif. Hal ini menyebabkan layanan lebih berfokus pada penanganan kasus akut saat demam terjadi, ketimbang pencegahan atau manajemen demam yang dilakukan di rumah oleh orang tua.

Selain itu, belum ada program khusus yang bertujuan untuk memberikan edukasi rutin kepada orang tua terkait manajemen demam di rumah. Edukasi yang diberikan lebih bersifat reaktif, tergantung pada kondisi anak saat mereka datang ke fasilitas kesehatan. Padahal, pemberian informasi yang lebih sistematis dan rutin kepada orang tua mengenai cara penanganan demam di rumah dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka serta mempercepat tindakan awal yang lebih tepat dan efektif ketika anak mengalami demam.

Penelitian ini melibatkan 268 orang tua atau *caregiver* di wilayah kerja Puskesmas 3-4 Ulu Palembang. Gambaran mengenai penanganan demam pada anak dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 41.1
Gambaran *Home Fever Remedies*

HFR n=268	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	145	54,1
Kurang	123	45,9

HFR: *Home Fever Remedies*

Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 145 orang tua atau pengasuh (54,1%) telah melakukan penanganan demam pada anak dengan baik, sedangkan sisanya, yaitu 45,9%, menunjukkan penanganan yang kurang baik. Penanganan demam yang baik mencakup pemahaman dan kemampuan untuk mengambil tindakan yang sesuai pada setiap fase demam, yaitu fase sub-klinis, fase klinis, dan fase lanjut. Fakta ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden memiliki kesadaran dan pengetahuan yang memadai dalam merespons kondisi demam anak secara terstruktur dan terarah.

Pada fase sub-klinis, tindakan yang tepat biasanya melibatkan pengamatan awal terhadap tanda-tanda demam dan pemberian intervensi ringan seperti memastikan asupan cairan cukup dan mencegah dehidrasi. Sebagian besar responden yang tergolong baik telah memahami pentingnya langkah ini sebagai bentuk pencegahan dini sebelum kondisi anak memburuk. Selanjutnya, pada fase klinis, tindakan yang dilakukan meliputi pemantauan suhu tubuh secara berkala,

pemberian antipiretik sesuai dosis, serta menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak, seperti menggunakan kompres hangat dan menjaga ventilasi ruangan. Di fase lanjut, yang mungkin melibatkan demam tinggi berkepanjangan, responden yang memiliki penanganan baik mampu mengenali gejala bahaya dan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan.

Namun, masih terdapat 45,9% orang tua atau pengasuh yang belum melakukan penanganan demam secara optimal di setiap fase. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan edukasi dan pelatihan terkait langkah-langkah penanganan demam yang benar. Penting untuk memberikan pemahaman kepada kelompok ini tentang risiko komplikasi yang dapat terjadi jika demam tidak ditangani dengan tepat. Dengan intervensi yang sesuai, diharapkan seluruh orang tua atau pengasuh dapat memberikan perawatan yang lebih baik dan efektif saat menghadapi demam pada anak di rumah.

Karakteristik orangtua atau caregiver pada penelitian ini dideskripsikan pada Tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2 Karakteristik Orangtua Dan Caregiver

Variabel	n =	Katagori	Frekuensi	Persentase (%)
	268			
HFR		Baik	145	54,1
		Kurang baik	123	45,9
Umur (tahun)		< 35	143	53,4
		≥ 35	125	46,6
Jenis kelamin		Female	237	88,4
		Male	31	11,6
Pendidikan		Elementary	35	13,1
		Senior		
		School	116	43,3
Pekerjaan		College	117	43,7
		Employed	136	41

Marital Status	Unemployed	132	49,3
	Married	257	95,9
	Single	11	4,1
Pendapatan keluarga (UMR)	> 3,677,591	103	38,4
	≤ 3,677,591	165	61,6
Pengetahuan tentang HFR	Baik	165	61,6
	Kurang baik	103	38,4
Sikap mengenai HFR	Baik	130	48,5
	Kurang baik	138	51,5

Analisis bivariat hubungan karakteristik orangtua/ *caregiver* dengan home fever remedies yang diuji dengan chi square disajikan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Hubungan Karakteristik Orangtua Dengan *Home Fever Remedies*

Variabel	Home Fever Remedies				P-value
	Baik		Kurang Baik		
	n	%	n	%	
Umur					0,401
<35 tahun	101	63,9	57	36,1	
≥35 tahun	70	58,3	50	41,7	
Jenis kelamin					0,79
Perempuan	152	61	97	39	
Laki-laki	19	65,5	10	34,5	
Pendidikan					0.000
SD- SMP	20	55,6	16	44,4	
SMU	52	43,3	68	56,7	
Perguruan Tinggi	99	81,1	23	18,9	
Pekerja					0.000

Bekerja	97	82,9	20	17,1	
Tidak bekerja	74	46	87	54	
Marital Status					0,345
Menikah	166	62,2	101	37,8	
Tidak menikah	5	45,5	6	54,5	
Pendapatan keluarga					0,004
> UMR	81	72,3	31	27,7	
≤ UMR	90	54,2	76	45,8	
Pengetahuan tentang HFR					0.000
Baik	130	72,2	50	27,8	
Kurang Baik	41	41,8	57	58,2	
Sikap mengenai HFR					0.000
Baik	103	73	38	27	
Kurang baik	68	49,6	69	50,4	

Dari Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 dapat dijelaskan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Umur

Distribusi karakteristik menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia <35 tahun sebanyak 143 orang (53,4%), sedangkan responden berusia ≥35 tahun sebanyak 125 orang (46,6%). Berdasarkan analisis bivariat, proporsi penanganan demam yang baik lebih banyak ditemukan pada responden berusia <35 tahun (63,9%) dibandingkan dengan ≥35 tahun (58,3%), meskipun hasil ini tidak signifikan secara statistik (p -value = 0,401). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun usia dapat mempengaruhi energi, kemampuan belajar, dan akses informasi, faktor usia bukanlah determinan utama dalam keberhasilan penanganan demam anak di rumah.

2. Jenis Kelamin

Sebagian besar responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan, yaitu 237 orang (88,4%), sedangkan laki-laki hanya 31 orang (11,6%). Pada analisis bivariat, proporsi penanganan demam yang baik pada perempuan mencapai 61%, sedangkan laki-laki sedikit lebih tinggi, yakni 65,5%, namun tidak signifikan ($p\text{-value} = 0,79$). Hal ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama dalam memahami dan menerapkan penanganan demam pada anak, meskipun peran perempuan sebagai pengasuh utama mungkin mempengaruhi dominasi jumlah partisipan perempuan.

3. Pendidikan

Karakteristik pendidikan menunjukkan bahwa 35 responden (13,1%) memiliki pendidikan dasar, 116 orang (43,3%) berpendidikan sekolah menengah, dan 117 orang (43,7%) memiliki pendidikan tinggi. Hasil analisis bivariat menunjukkan hubungan signifikan antara pendidikan dan kualitas HFR ($p\text{-value} = 0,000$), di mana responden dengan pendidikan perguruan tinggi memiliki proporsi penanganan demam baik tertinggi (81,1%). Sebaliknya, responden dengan pendidikan sekolah menengah cenderung memiliki proporsi kurang baik yang lebih besar (56,7%). Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan berperan penting dalam memahami konsep, penerapan, dan evaluasi penanganan demam di rumah.

4. Pekerjaan

Distribusi karakteristik pekerjaan menunjukkan bahwa 136 responden (50,7%) bekerja, sementara 132 responden (49,3%) tidak bekerja. Berdasarkan analisis bivariat, terdapat hubungan signifikan antara pekerjaan

dan kualitas HFR ($p\text{-value} = 0,000$). Responden yang bekerja memiliki proporsi penanganan demam baik sebesar 82,9%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang tidak bekerja (46%). Hal ini dapat dikaitkan dengan akses informasi yang lebih baik dan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh kelompok yang bekerja, sehingga mereka dapat menerapkan langkah-langkah penanganan demam secara lebih optimal.

5. Marital status

Sebagian besar responden berstatus menikah, yaitu 257 orang (95,9%), sementara responden yang tidak menikah hanya 11 orang (4,1%). Analisis bivariat menunjukkan bahwa status pernikahan tidak memiliki hubungan signifikan dengan kualitas HFR ($p\text{-value} = 0,345$). Responden yang menikah memiliki proporsi penanganan demam baik sebesar 62,2%, sedangkan yang tidak menikah memiliki proporsi lebih rendah, yakni 45,5%. Meskipun demikian, status pernikahan dapat memberikan dukungan emosional dan praktis yang lebih baik dalam menangani demam anak di rumah.

6. Pendapatan keluarga

Distribusi pendapatan keluarga menunjukkan bahwa sebanyak 103 responden (38,4%) memiliki pendapatan $>$ UMR, sedangkan 165 responden (61,6%) berpendapatan $\leq$ UMR. Hasil analisis bivariat menunjukkan hubungan signifikan antara pendapatan dan kualitas HFR ($p\text{-value} = 0,004$). Responden dengan pendapatan $>$ UMR memiliki proporsi penanganan demam baik sebesar 72,3%, sementara kelompok dengan pendapatan $\leq$ UMR lebih rendah, yakni 54,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan keluarga memengaruhi akses terhadap fasilitas kesehatan, obat-obatan, dan

informasi yang mendukung penanganan demam anak secara optimal.

7. Pengetahuan mengenai *home fever remedies*

Pengetahuan tentang HFR meliputi pemahaman definisi, penyebab, penerapan, dan evaluasi penanganan demam. Sebanyak 165 responden (61,6%) memiliki pengetahuan baik, sementara 103 responden (38,4%) memiliki pengetahuan kurang baik. Analisis bivariat menunjukkan hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan kualitas HFR ($p\text{-value} = 0,000$). Responden dengan pengetahuan baik memiliki proporsi penanganan demam baik sebesar 72,2%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan responden berpengetahuan kurang baik (41,8%). Hal ini menekankan pentingnya edukasi kesehatan dalam meningkatkan kemampuan penanganan demam di rumah.

8. Sikap terhadap *home fever remedies*

Sikap orang tua terhadap HFR mencakup penerimaan, kepercayaan, dan internalisasi tindakan penanganan demam. Distribusi karakteristik menunjukkan bahwa 130 responden (48,5%) memiliki sikap baik, sementara 138 responden (51,5%) memiliki sikap kurang baik. Hasil analisis bivariat menunjukkan hubungan signifikan antara sikap dan kualitas HFR ($p\text{-value} = 0,000$). Responden dengan sikap baik memiliki proporsi penanganan demam baik sebesar 73%, sedangkan yang memiliki sikap kurang baik hanya 49,6%. Hal ini menunjukkan bahwa sikap positif berperan penting dalam mendorong penerapan langkah-langkah penanganan demam anak secara efektif.

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik ganda, ditemukan bahwa terdapat empat variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas penanganan demam anak di rumah (*Home Fever Remedies*), yaitu pendidikan, pekerjaan, pengetahuan dan sikap mengenai HFR. Dari keempat variabel tersebut, pekerjaan menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kemampuan orang tua atau caregiver dalam menangani demam anak secara optimal.

Tabel 4.4 Model Prediksi Home Fever Remedies

Variabel	B	S.E	Exp (B)	P-value*	95% C.I	
					Lower	Upper
Pendidikan	-			0,002		
SMU	0,175	0,465	0,840	0,007	0,337	2,091
Perguruan Tinggi	0,924	0,429	2,518	0,031	1,086	5,839
Pekerjaan	1,286	0,330	3,617	0,000	1,893	6,910
Pengetahuan tentang HFR	0,959	0,293	2,610	0,001	1,471	4,631
Sikap mengenai HFR	0,904	0,303	2,469	0,003	1,363	4.471,000
Constant	2,504	0,562	0,082	0,000		

*** logistic regression test**

Hasil penelitian membuktikan bahwa keempat variabel pada Tabel 4.4 di atas statistik berperan dalam memprediksi sejauh mana orang tua atau caregiver mampu menangani demam anak dengan baik.

1. Pendidikan

Variabel pendidikan menunjukkan hasil yang signifikan dengan $p\text{-value} = 0,002$. Secara spesifik,

pendidikan tingkat Perguruan Tinggi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas HFR, dengan nilai $\text{Exp}(B)=2,518$ ($\text{CI}=1,086-5,839$). Hal ini menunjukkan bahwa orang tua dengan pendidikan perguruan tinggi memiliki peluang 2,5 kali lebih besar untuk melakukan penanganan demam anak dengan baik dibandingkan mereka yang hanya berpendidikan dasar atau sekolah menengah. Sementara itu, tingkat pendidikan SMU memiliki nilai negatif pada koefisien regresi ($B=-0,175$) dan tidak menunjukkan pengaruh positif yang signifikan. Hal ini menekankan pentingnya tingkat pendidikan yang lebih tinggi dalam meningkatkan kemampuan orang tua untuk memahami dan menerapkan penanganan demam yang tepat.

2. Pekerjaan

Variabel pekerjaan merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kualitas HFR, dengan nilai $\text{Exp}(B)=3,617$ ($\text{CI}=1,893-6,910$) dan $p\text{-value}=0,000$. Hal ini menunjukkan hasil yang signifikan. Orang tua atau caregiver yang bekerja memiliki peluang 3,6 kali lebih besar untuk melakukan penanganan demam anak dengan baik dibandingkan mereka yang tidak bekerja. Hal ini dapat dikaitkan dengan akses yang lebih baik terhadap sumber daya, informasi kesehatan, dan kemampuan ekonomi yang memungkinkan para pekerja untuk mendapatkan pengetahuan dan fasilitas pendukung dalam menangani demam di rumah.

3. Pengetahuan

Pengetahuan mengenai HFR juga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas penanganan demam, dengan $p\text{-value} = 0,001$. Nilai $\text{Exp}(B) = 2,610$ menunjukkan bahwa responden dengan pengetahuan baik memiliki peluang 2,6 kali lebih besar untuk

menangani demam anak secara optimal dibandingkan dengan mereka yang memiliki pengetahuan kurang baik. Rentang *confidence interval* untuk variabel ini adalah 1,471–4,631, yang menunjukkan kepercayaan tinggi pada hasil ini. Pengetahuan tentang HFR meliputi pemahaman definisi, penyebab, penerapan, dan evaluasi tindakan, yang berperan penting dalam membekali orang tua dengan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam menangani demam anak di rumah.

4. Sikap

Sikap orang tua terhadap HFR turut mempengaruhi kualitas penanganan demam anak, dengan nilai $\text{Exp (B)} = 2,469$ dan $p\text{-value} = 0,003$. Rentang *confidence interval* antara 1,363–4,471 menunjukkan bahwa hasil ini signifikan secara statistik. Responden dengan sikap positif terhadap HFR memiliki peluang 2,5 kali lebih besar untuk menerapkan langkah-langkah penanganan demam anak secara efektif. Sikap ini mencerminkan penerimaan, kepercayaan, dan internalisasi terhadap pentingnya penerapan HFR, yang memotivasi orang tua untuk melakukan tindakan yang tepat dan sistematis dalam menangani demam anak

Hasil ini menunjukkan pentingnya intervensi yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan sikap mengenai HFR, terutama bagi kelompok dengan pendidikan rendah dan tidak bekerja. Program edukasi kesehatan perlu diarahkan untuk memperkuat pemahaman orang tua mengenai demam dan penanganannya. Selain itu, kebijakan yang mendukung akses informasi kesehatan dan pelatihan praktis bagi orang tua atau caregiver juga penting untuk diimplementasikan. Dengan memperhatikan faktor-faktor

prediktif ini, diharapkan kualitas penanganan demam anak di rumah dapat ditingkatkan secara signifikan.

BAB 5

PENUTUP

Demam pada anak merupakan kondisi yang umum terjadi, namun penanganannya sering kali menjadi tantangan bagi orang tua atau pengasuh. Pemahaman yang memadai tentang cara menangani demam dengan benar di rumah dapat membantu mengurangi risiko komplikasi serius dan meningkatkan kualitas perawatan. Meskipun banyak orang tua memiliki pengetahuan dasar tentang penanganan demam, tidak jarang terdapat keraguan atau kekeliruan dalam mengambil langkah yang tepat. Pengetahuan yang baik tentang tindakan yang sesuai, seperti mengenali gejala yang memerlukan perhatian medis lebih lanjut, menjadi kunci untuk memastikan perawatan yang efektif.

Sikap positif dan kesiapan orang tua dalam menangani demam juga memainkan peran penting. Orang tua yang percaya diri dan siap bertindak cenderung lebih mampu merespons demam dengan langkah yang benar. Sebaliknya, sikap yang cemas atau kurang percaya diri dapat menyebabkan keterlambatan dalam tindakan, yang berpotensi memperburuk kondisi anak. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran dan memberikan edukasi yang membantu orang tua merasa lebih yakin dan siap dalam menghadapi situasi ini.

Edukasi tentang penanganan demam harus mencakup informasi yang jelas mengenai perbedaan antara demam biasa dan demam yang memerlukan perhatian medis segera. Ini bertujuan untuk mengurangi kekhawatiran yang tidak

perlu sekaligus memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kapan tindakan medis diperlukan. Selain itu, memperluas akses ke informasi yang valid dan terpercaya sangat penting, terutama di era digital saat ini, di mana informasi yang salah mudah tersebar.

Faktor seperti pendidikan orang tua, pekerjaan, dan pendapatan keluarga juga memengaruhi kemampuan mereka dalam menangani demam anak. Orang tua dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memahami pentingnya langkah yang tepat, sementara pekerjaan sering kali menjadi hambatan dalam memberikan perhatian penuh kepada anak yang demam. Dukungan kebijakan yang memungkinkan fleksibilitas kerja bagi orang tua dapat membantu mereka lebih responsif terhadap kebutuhan kesehatan anak.

Meningkatkan literasi kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama untuk mendukung penanganan demam di rumah. Program penyuluhan berbasis komunitas dapat memberikan manfaat besar, terutama di daerah yang sulit dijangkau layanan kesehatan. Selain itu, memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi kesehatan atau video edukasi, dapat menjadi solusi untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Dengan akses yang lebih mudah, orang tua dapat lebih memahami langkah-langkah penanganan yang tepat tanpa harus bergantung pada fasilitas medis setiap saat.

Selain meningkatkan pengetahuan, penting juga untuk menumbuhkan sikap yang mendukung tindakan cepat dan tepat. Orang tua yang memiliki sikap positif cenderung lebih sigap dalam merawat anak yang demam, sehingga risiko komplikasi dapat diminimalkan. Penyuluhan yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun

kepercayaan diri, dapat membantu mengatasi hambatan psikologis yang sering kali muncul.

Peningkatan pemahaman tentang penanganan demam tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada layanan kesehatan yang terbatas dan memberikan perawatan yang lebih efektif di rumah. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi beban fasilitas kesehatan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga secara umum.

Sebagai penutup, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi orang tua dan pengasuh dalam menangani demam pada anak. Pengetahuan yang memadai, sikap yang positif, dan akses terhadap informasi yang akurat adalah kunci untuk memastikan perawatan yang lebih baik. Dengan langkah-langkah yang sederhana namun efektif, setiap keluarga dapat memberikan perawatan yang optimal bagi anak-anak mereka, membantu mencegah komplikasi, dan mendukung kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, S., Kumar, M., & Chakole, S. (2023). Nurturing the Next Generation: Health Challenges in Infants and Children Across Asia and Africa. *Cureus*, 15(7), 1–6. <https://doi.org/10.7759/cureus.42573>
- Agustiawan, F., Yuniati, I., Wulandari, A., Badi'ah, N. A., Maftukhah, K. E., Wicaksono, D. F., Albyn, K. M., Putri, A., Nirbaya, R., Garmini, M. L. B., Aran, B., Yulianto, D. L., & Setyowati, R. Pastuty, Anwar, H. D. Damanik, Maksuk, P. Rio Purnama, Zairinayati, dan M. (2022). *Kesehatan Masyarakat Dan Kesehatan Lingkungan* (Issue March).
- Andari, F. N., Faizah, N., Yogananda, A. A., & Halal, I. (2022). *Jurnal Ilmiah Kefarmasian THE CORRELATION BETWEEN SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS AND THE PARENTS KNOWLEDGE ABOUT HANDLING CHILDREN ' S* 4(2), 35–43.
- Arias, D. P., Chen, T., & Moles, R. (2019). Educational Interventions on Fever Management in Children: A Scoping Review. *Nursing Open*, 6(3), 713–721. <https://doi.org/10.1002/nop2.294>
- Arthur, E. (2014). Socio-economic correlates and choice of treatment of childhood fever in Ghana. *African Population Studies*, 28(0), 946–955. <http://aps.journals.ac.za/pub/article/view/548/450>
- Banjarnahor, E. R. D., Fathorrazi, M., & Sarwedi. (2015). Pengaruh Faktor Pendapatan Keluarga, Pendidikan Ibu, Jumlah Anak dan Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan terhadap Status Gizi Balita di Desa Gunung Sari

Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–4.

- Beerenbrock, Y., Jenetzky, E., & Martin, D. D. (2024). FeverApp for Parents: A Multilingual and Socially Accountable Approach to Paediatric Fever Management in Germany. *Journal of CME*, 13(1). <https://doi.org/10.1080/28338073.2024.2352940>
- Berman, A., Kozier, B. & Erb, G. L. (2015). Kozier and Erb's Fundamentals of Nursing (3rd Australian ed.). *Pearson Education*, June 2018, 94–95.
- Betz, C. L. (2005). Health care disparities of children and youth: A pediatric nursing concern. *Journal of Pediatric Nursing*, 20(6), 399–401. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2005.10.001>
- Carlson, & Kurnia, B. (2020). Tatalaksana Demam Tifoid Pada Anak. *Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta, Indonesia*, 47(9), 698–702.
- Carroll, J., & Klein, N. (20019). *Clinical manual of fever in children* (A. S. El-Radhi (ed.); I). Springer International Publishing.
- Chung, A. M. (2020). An evaluation of community pharmacy recommendations regarding alternating antipyretics in children. *Journal of the American Pharmacists Association*, 60(2), 368-373.e1. <https://doi.org/10.1016/j.japh.2018.06.015>
- Dabis, F., Orne-Gliemann, J., Perez, F., Leroy, V., Newell, M. L., Coutoudis, A., & Coovadia, H. (2002). Improving child health: The role of research. *British Medical Journal*, 324(7351), 1444–1447. <https://doi.org/10.1136/bmj.324.7351.1444>

- Dai, Y. T., & Lu, S. H. (2012). What's missing for evidence-based fever management? Is fever beneficial or harmful to humans? *International Journal of Nursing Studies*, 49(5), 505–507.
<https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.11.006>
- Dinas Kesehatan Kota Palembang. (2022). *Profil Kesehatan Kota Palembang Tahun 2021*. 218.
- Elajez, R. H., Corporation, H. M., Mohamed, T., Corporation, H. M., Hassan, F., Toaimah, S., & Corporation, H. M. (2021). *Parents ' Knowledge , Attitudes and Beliefs Regarding Fever in Children : A Parents ' Knowledge , Attitudes and Beliefs Regarding Fever in Children : A Cross-Sectional Study In Qatar. August*.
<https://doi.org/10.19080/AJPN.2021.10.555842>
- Fadilla, R. F., & Gayatri, A. (2022). Pengetahuan Orang Tua dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dengan Pola Swamedikasi Demam pada Anak di DKI Jakarta. *Generics: Journal of Research in Pharmacy*, 2(2), 113–118.
<https://doi.org/10.14710/genres.v2i2.15796>
- Fibritiani, A., Pirmansyah, M. T., Darmayanti, W., & Suban, E. (2023). *Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu dengan Penanganan Demam pada Anak di Wilayah Kerja Puskesmas Kronjo Tahun 2022*. 6.
- Friedman, M. ., Bowden, V. ., & Jones, E. . (2003). *Family Nursing: Research, Theory, & Practice* (5th ed.). Pearson Education Inc.
- Green, L. W., & Glasgow, R. E. (2006). Evaluating the relevance, generalization, and applicability of research: Issues in external validation and translation methodology.

Evaluation and the Health Professions, 29(1), 126–153. <https://doi.org/10.1177/0163278705284445>

Green, R., Webb, D., Jeena, P. M., Wells, M., Butt, N., Hangoma, J. M., Moodley, R. (Sham), Maimin, J., Wibbelink, M., & Mustafa, F. (2021). Management of acute fever in children: Consensus recommendations for community and primary healthcare providers in sub-Saharan Africa. *African Journal of Emergency Medicine*, 11(2), 283–296. <https://doi.org/10.1016/j.afjem.2020.11.004>

Gulcan, M. K., & Sahiner, N. C. (2023). Determining the fever-related knowledge and practices of mothers with children aged 1–5 years presenting to a child emergency service with fever complaints in Türkiye. *Journal of Pediatric Nursing*, 69, e13–e20. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2022.11.024>

Hamideh Kerdar, S., Himbert, C., Martin, D. D., & Jenetzky, E. (2021). Cross-sectional study of parental knowledge, behaviour and anxiety in management of paediatric fever among German parents. *BMJ Open*, 11(10), 1–9. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-054742>

Howard, A. K., & Morgan, J. A. (2019). Managing fevers in otherwise healthy children. *U.S. Pharmacist*, 44(5), 22–25.

Istiyati, S.; Nuzuliana, R.; Shalihah, M. (2020). Gambaran peran ayah dalam pengasuhan. *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian*, 17(2), 12–19. <https://journals.itspku.ac.id/index.php/profesi/article/view/22>

Kemenkes RI. (2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018.

Kementrian Kesehatan RI, 53(9), 1689–1699.

- Kurniawati, D., Gaghauna, E. E. ., & Ariani, M. (2021). Handling Fever In Toddlers At Homes In The Village Of Manarap Lama. *Jurnal Empathy Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 96–107. <https://doi.org/10.37341/jurnalempathy.v0i0.64>
- Nakahara, S., Poudel, K. C., Lopchan, M., Poudel, O. R., Poudel-Tandukar, K., & Ichikawa, M. (2010). Differential effects of out-of-home day care in improving child nutrition and augmenting maternal income among those with and without childcare support: A prospective before-after comparison study in Pokhara, Nepal. *Health Policy*, 97(1), 16–25. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2010.02.011>
- National Institute For Health and Care Excellence. (2021). *Fever in under 5s: assessment and initial management Clinical guideline*. <https://www.nice.org.uk/guidance/ng143>
- Ng, H. L., Li, H., Jin, X., Lee, C., & Id, W. (2023). *towards childhood fever among South-East and East Asian parents : A literature review*. 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290172>
- NICE guidelines. (2013). *Fever in under 5s: assessment and initial management Clinical guideline. November 2019*.
- Ogunyinka, I. A., Oshikoya, K. A., Yusuff, K. B., Tahir, Y., Yahaya, M., Adeniyi, S. B., & Oforkansi, I. E. (2023). *knowledge and practices. August*, 1–14. <https://doi.org/10.3389/fped.2023.1119067>
- Park, Y., Kim, S. R., Seo, H. J., & Cho, J. (2024). Health Literacy in Fall-Prevention Strategy: A Scoping Review. *Asian*

- Pereira, G. L., Tavares, N. U. L., Mengue, S. S., & Da S. Dal Pizzol, T. (2013). Therapeutic procedures and use of alternating antipyretic drugs for fever management in children. *Jornal de Pediatria*, 89(1), 25–32. <https://doi.org/10.1016/j.jped.2013.02.005>
- Perez, F., Ba, H., Dastagire, S. G., & Altmann, M. (2009). The role of community health workers in improving child health programmes in Mali. *BMC International Health and Human Rights*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/1472-698X-9-28>
- Pitoli, P. J., Duarte, B. K., Fragoso, A. A., Damaceno, D. G., & Sanches Marin, M. J. (2021). Fever in children: Parents' search for urgent and emergency services. *Ciencia e Saude Coletiva*, 26(2), 445–454. <https://doi.org/10.1590/1413-81232021262.40782020>
- Puspitosari, A., & Hartono, H. (2022). Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Penanganan Demam Pada Anak Di Apotek Sehat Sukoharjo. *Jurnal Farmaku (Farmasi Muhammadiyah Kuningan)*, 7(2), 48–55. <https://doi.org/10.55093/jurnalfarmaku.v7i2.291>
- Raak, C., Scharbrodt, W., Berger, B., Boehm, K., & Martin, D. (2022). The use of calf compresses for gentle fever reduction- What do we know? A scoping review. *Collegian*, 29(5), 598–611. <https://doi.org/10.1016/j.colegn.2022.01.010>
- Rahman, A., & Hossain, M. M. (2022). Prevalence and determinants of fever, ARI and diarrhea among

- children aged 6–59 months in Bangladesh. *BMC Pediatrics*, 22(1), 1–13.
<https://doi.org/10.1186/s12887-022-03166-9>
- Sakr, F., Toufaily, Z., Akiki, Z., Akel, M., Malaeb, D., Dabbous, M., & Salameh, P. (2022). Fever among preschool-aged children: A cross-sectional study assessing Lebanese parents' knowledge, attitudes and practices regarding paediatric fever assessment and management. *BMJ Open*, 12(10).
<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-063013>
- Schellack, N., & Schellack, G. (2018). An overview of the management of fever and its possible complications in infants and toddlers. *SA Pharmaceutical Journal*, 85(1), 26–33.
- Setiani, S., Saputri, M. E., & Wowor, T. J. F. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Self Management Demam Pada Anak Usia Toodler Diruang Teratai Rsab Harapan Kita Jakarta 2021. *Jurnal Penelitian Keperawatan Kontemporer*, 2(1), 130–139.
<https://doi.org/10.59894/jpkk.v2i1.307>
- Silviyana, Cahyaningrum, E. D., & Ema Wahyu Ningrum. (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan Orangtua Tentang Demam Dengan Pengelolaan Demam Pada Anak Di Puskesmas Pangadegan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(1), 345–362.
- Souza, M. V. de, Souza, D. M. de, Damião, E. B. C., Buchhorn, S. M. M., Rossato, L. M., & Salvetti, M. de G. (2022). Effectiveness of warm compresses in reducing the temperature of febrile children: A pilot randomized clinical trial. *Revista Da Escola de Enfermagem Da*

USP, 56, 1–9. <https://doi.org/10.1590/1980-220x-reeusp-2022-0168en>

- Subedi, S., Basnet, S., Rijal, A., Chaugai, R., Prakash, P., Chhetri, B. T., & Shah, S. K. (2022). Perception and practice regarding management of childhood fever among parents of under five children in tertiary level of hospital, Nepal. *International Journal Of Community Medicine And Public Health*, 9(7), 2815. <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20221743>
- Sudibyo, D. G., Anindra, R. P., Gihart, Y. El, Ni'azzah, R. A., Kharisma, N., Pratiwi, S. C., Chelsea, S. D., Sari, R. F., Arista, I., Damayanti, V. M., Azizah, E. W., Poerwantoro, E., Fatmaningrum, H., & Hermansyah, A. (2020). Pengetahuan Ibu Dan Cara Penanganan Demam Pada Anak. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 7(2), 69. <https://doi.org/10.20473/jfk.v7i2.21808>
- Suryagustina, S., Prinawati, P., & Indrawan, I. (2022). Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Keluarga dalam Penanganan Kejang Demam pada Anak: Literature Review. *Ahmar Metastasis Health Journal*, 2(2), 52–62. <https://doi.org/10.53770/amhj.v2i2.119>
- Swarjana, I. K. (2022). *Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Persepsi, Stress, Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pandemi Covid-19, Akses Layanan Kesehatan* (R. Indra (ed.); I). CV Andi Offset.
- Tavan, A., Monemi, E., Keshavarz, F., Kazemi, B., & Nematollahi, M. (2022). The effect of simulation-based education on parental management of fever in children: a

- quasi-experimental study. *BMC Nursing*, 21(1), 1–8.
<https://doi.org/10.1186/s12912-022-00938-7>
- Tchamo, S. H., Michel, A., Djogang, Y., Omer, N., Jonas, K., & Marlène, O. (2022). *Management of Fever By Traditional and Modern Medicine in the Ndé Division: Comparative and Experimental Study*. February.
<https://doi.org/10.24941/ijcr.42766.01.2022>
- Tian, Z., Hazen, N., & Jacobvitz, D. B. (2023). Triadic family interactions at 2 years: The role of prenatal marital quality and infants' attachment configuration with mother and father. *Attachment and Human Development*, 25(5), 524–543.
<https://doi.org/10.1080/14616734.2023.2257677>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- UNICEF. (2019). For Every Child, Vaccination. In *UNICEF Tanzania Annual Report*. UNICEF.
http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ_های_رسانه&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chckhashk=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component
- Urbane, U. N., Likopa, Z., Gardovska, D., & Pavare, J. (2019). Beliefs, practices and health care seeking behavior of parents regarding fever in children. *Medicina (Lithuania)*, 55(7), 1–12.
<https://doi.org/10.3390/medicina55070398>

- Walsh, A. M. (2007). Parents ' Management of Childhood Fever. *Childhood A Global Journal Of Child Research*, November, 1–413.
- Watt, F., Kennedy, D., Seymour, M., & Vincent, T. (2010). 539 Experience From a Multi-Disciplinary Dedicated Hand Osteoarthritis Clinic: the Role of Corticosteroid Intra-Articular Injection As Part of an Individualised Treatment Programme. In *Osteoarthritis and Cartilage* (Vol. 18). [https://doi.org/10.1016/s1063-4584\(10\)60566-3](https://doi.org/10.1016/s1063-4584(10)60566-3)
- Wayan, N., Adnyani, S., Ketut, N., & Sugiartini, A. (2022). *Parents ' Anxiety Level Regarding Handling Fever in Toddlers Due to Corona Virus Deasses at Rowosari Community Health Center, Semarang City*. 3(1), 10–15.
- Wilson, K. M., Beggs, S. A., Zosky, G. R., Bereznicki, L. R., & Bereznicki, B. J. (2019). Parental knowledge, beliefs and management of childhood fever in Australia: A nationwide survey. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 44(5), 768–774. <https://doi.org/10.1111/jcpt.13000>
- Yuniati, F., Erwin, E., Shobur, S., & Ardianty, S. (2025). *Home fever management in children : a systematic review*. 14(1), 529–538. <https://doi.org/10.11591/ijphs.v14i1.24554>

GLOSARIUM

H

HFR: *Home Fever Remedies* adalah penanganan demam di rumah

PROFIL PENULIS



Dr. Faiza Yuniati, S.Pd., S.Kep., M.KM., Lahir di Palembang, 26 Juni 1976. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari tingkat Diploma yaitu Akademi Keperawatan Depkes Palembang tahun 1993 dan lulus tahun 1996. Kemudian tahun 1997 melanjutkan Pendidikan jenjang S1 pada Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya dan lulus tahun 2000. Tahun 2004 melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Peminatan Biostatistik dan Kependudukan di Universitas

Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020 dengan beasiswa dari LPDP. Pada tahun 2022 mengikuti perkuliahan di Program Sarjana Ilmu Keperawatan Institut Kesehatan dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Palembang dan lulus pada tahun 2024. Pada tahun 1999 sampai 2003 bertugas sebagai perawat pelaksana di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hoesin Palembang. Sejak tahun 2003 hingga saat ini bertugas sebagai Dosen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang. Sejak tahun 2011 aktif mengikuti berbagai konferensi, seminar dan pelatihan pada event Nasional maupun Internasional sebagai oral presenter maupun anggota. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi artikel ilmiah, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: faizayuniati@poltekkespalembang.ac.id

Motto: ""Setiap langkah kecil menuju pengetahuan adalah investasi besar untuk masa depan."

PROFIL PENULIS



Sherli Shobur, S.KM., M.KM., Penulis merupakan dosen profesional yang mengabdikan di Institusi di bawah naungan Kementerian Kesehatan, Politeknik Kesehatan Jurusan Keperawatan sejak tahun 2001. Minat dan ketertarikan penulis terhadap ilmu kesehatan dimulai sejak tahun 1996 pada saat menimba ilmu di Program Diploma III Keperawatan Depkes Palembang yang diselesaikan pada

tahun 1999. Minat ini juga membuat penulis melanjutkan studi S1 ke Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan memilih Jurusan Administrasi Kebijakan Kesehatan dan berhasil diselesaikan pada Tahun 2002. Setahun berselang, penulis langsung melanjutkan ke S2 di Ilmu Kesehatan Masyarakat UI dengan kembali memilih Jurusan Administrasi Kebijakan Kesehatan dengan spesifikasi bidang manajemen dan berhasil diselesaikan pada tahun 2005. Sebagai dosen yang dituntut tidak hanya memberikan bimbingan dan pengajaran, penulis juga aktif sebagai peneliti yang berkaitan dibidang keahliannya tersebut. Penelitian yang telah dilakukan penulis sebagian besar dibiayai oleh internal perguruan tinggi dan juga Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI. Selain sebagai peneliti, penulis juga aktif di dalam organisasi – organisasi baik yang terkait dengan kesehatan maupun organisasi keagamaan. Penulis juga aktif memberikan bimbingan terkait dengan kesehatan bagi jamaah haji dan umroh dan sudah mendapatkan sertifikasi sebagai pembimbing profesional. Menulis buku merupakan kontribusi penulis kepada generasi penerus bangsa agar bisa bermanfaat dan terus bisa memberikan manfaat dengan ilmu – ilmu yang sudah didapatkan penulis secara teori selama mengikuti pendidikan maupun praktek langsung yang didapatkan dari pengalaman – pengalaman pribadi penulis selama di lapangan.

Email Penulis: sherlishobur@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Monograf ini mengkaji penanganan demam anak di rumah oleh orang tua atau caregiver, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perawatan di rumah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, monograf ini menyimpulkan bahwa meskipun sebagian besar orang tua memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai penanganan demam, masih banyak yang kurang yakin atau ragu dalam mengambil tindakan yang tepat. Pengetahuan, sikap positif, pendidikan, dan pekerjaan orang tua berperan penting dalam menentukan efektivitas penanganan demam pada anak. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti usia, pendapatan, serta pemahaman yang lebih baik tentang gejala dan cara penanganan demam sangat mempengaruhi keputusan orang tua dalam memberikan perawatan yang sesuai.

Monograf ini juga mencatat bahwa meskipun banyak orang tua telah memiliki pengetahuan dasar, mereka tetap terhambat oleh ketidakpastian atau kurangnya kepercayaan diri dalam mengelola kondisi demam anak. Salah satu temuan utama adalah pentingnya sikap positif dan kesiapan orang tua dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan segera setelah mendeteksi demam. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya upaya edukasi yang lebih intensif mengenai penanganan demam melalui berbagai saluran komunikasi, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perawatan di rumah.

Melalui hasil penelitian ini, monograf ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran orang tua dalam merawat anak mereka saat demam, serta implikasi bagi kesehatan masyarakat. Pengetahuan yang lebih baik tentang penanganan demam dapat mengurangi ketergantungan pada perawatan medis yang tidak diperlukan, sehingga meringankan beban pada fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Monograf ini juga memberikan rekomendasi bagi pihak berwenang dan masyarakat untuk meningkatkan literasi kesehatan melalui penyuluhan yang lebih luas, guna membantu orang tua memberikan perawatan yang lebih efektif dan aman bagi anak-anak mereka.

Monograf ini mengkaji penanganan demam anak di rumah oleh orang tua atau caregiver, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perawatan di rumah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, monograf ini menyimpulkan bahwa meskipun sebagian besar orang tua memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai penanganan demam, masih banyak yang kurang yakin atau ragu dalam mengambil tindakan yang tepat. Pengetahuan, sikap positif, pendidikan, dan pekerjaan orang tua berperan penting dalam menentukan efektivitas penanganan demam pada anak. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti usia, pendapatan, serta pemahaman yang lebih baik tentang gejala dan cara penanganan demam sangat mempengaruhi keputusan orang tua dalam memberikan perawatan yang sesuai. Monograf ini juga mencatat bahwa meskipun banyak orang tua telah memiliki pengetahuan dasar, mereka tetap terhambat oleh ketidakpastian atau kurangnya kepercayaan diri dalam mengelola kondisi demam anak. Salah satu temuan utama adalah pentingnya sikap positif dan kesiapan orang tua dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan segera setelah mendeteksi demam. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya upaya edukasi yang lebih intensif mengenai penanganan demam melalui berbagai saluran komunikasi, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perawatan di rumah. Melalui hasil penelitian ini, monograf ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran orang tua dalam merawat anak mereka saat demam, serta implikasi bagi kesehatan masyarakat. Pengetahuan yang lebih baik tentang penanganan demam dapat mengurangi ketergantungan pada perawatan medis yang tidak diperlukan, sehingga meringankan beban pada fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Monograf ini juga memberikan rekomendasi bagi pihak berwenang dan masyarakat untuk meningkatkan literasi kesehatan melalui penyuluhan yang lebih luas, guna membantu orang tua memberikan perawatan yang lebih efektif dan aman bagi anak-anak mereka.



Penerbit:
PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919

